

اصلاحیه فایل نمونه سؤال 2، همراه با تشکر از دو بزرگوار، دکتر مشکبید و دکتر ترکمان تقدیم می شود

1. کمک مالی به مراجع؟

❖ در فصل چهارم. کتاب اخلاق خانم حسینیان گفته شده که روان شناس باید از شروع هر رابطه غیر حرفه ای مانند کاری یا مالی خودداری کند. اگر چنین رابطه ای برقرار شود؛ به عینیت روان شناس آسیب می رسد. یا در ایفای نقش او اختلال ایجاد می کند.

در کتاب مشاوره آسیب زا گفته شده که مددکاری به جای مشاوره از مصاریق مشاوره آسیب زاست.

2. انتقال متقابل؟

❖ انتقال متقابل شکل دیگه ای از انتقاله که انتقال از جانب مشاور به مراجعه. خیلی از افراد در فعالیتهای داوطلبانه کمک به دیگران در واقع دنبال رفع نیازهایی هستن که خودشون از وجودش بی خبرن و مشاوران از این قاعده مستثنی نیستن. درمانگران به علت اینکه مثل هر انسانی دارای ضعفا و کمبودایی هستن ممکنه فضای مشاوره برای تامین بخشی از یا تمام نیازای خودشون انتخاب کنند و فرایند آسیب زایی در این فضا بوجود بیاد.

3. بیان مسائل شخصی روان شناس در جلسه؟

❖ نکته 74- خلاصه گلدارد. مواقعی وجود دارد که به دلایلی مراجع در دیدن راه حلی که در نظر مشاور بدیهی است ناکام میماند در چنین مواقعی است که مشاور میتواند در مورد آن راه حل صحبت کند با این وجود، هنگامی که مشاور عقیده خود را پیش می کشد بهتر است به صورتی موقتی و آزمایشی بیان شود به نحوی که مراجع عقیده او را چیزی بیش از یک پیشنهاد در نظر نگیرد.

4. پویایی موضع قدرت روان شناس؟

❖ راجرز می گه: همخوانی. همدلی و پذیرش بی قید و شرط و موفقیت در انتقال وظیفه ما هس. چون تمام ابعاد مشاوره متاثر از ویژگی هایی که مراجع از ارتباط خود با مشاور ادراک می کنه و نه تکنیک ها.

5. استفاده از فناوری و تجهیزات در جلسه؟

❖ طبق بند 4_4 رازداری. برای استفاده از فناوری و تجهیزات برای ریکورد و غیره نیاز به اجازه مراجع می باشد یا قیم قانونیشون.

6. تغییر صحبت به شکل ناگهانی؟

❖ تغییر ناگهانی صحبت از سمت مشاور اشتباه است چون نباید جلوتر از مراجع پیش بره یا در صحبت های او خللی ایجاد کنه.

7. درخواست تکلیف از سمت مراجع؟

❖ در مورد درخواست تکلیف از سمت مراجع؛ میشه با مشاور بررسی بشه و به توافق برسن.

8. تفسیر و گزاره تشخیصی؟

❖ گزاره های تشخیصی ص 20 اخلاق در مشاوره موجوده. مصاحبه بینش گرا و مصاحبه علامت گرا هم مطالعه شود.

9. تماس چشمی با مراجع؟

❖ نکته 31 گلدارد میگه: تماس چشمی مداوم غیر عادی میشه و در نهایت میرسه به جدال چشمی. وقتی مراجع سکوت می کنه میشه با تماس چشمی توجه رو نشون داد.

10. در کدام تکنیک مراجع از مطالبی صحبت خواهد کرد که؛ مایل به آشکار شدن آن ها نیست؟

❖ تغییر جهت. در کتاب اوتر می خوانیم که: تغییر جهت دادن مسیر مصاحبه، پرداختن به یک مشکل از مسیر و جهت دیگر است. با استفاده از این تکنیک بیمار درباره مطالبی صحبت خواهد کرد که مایل به آشکار شدن آنها نیست. به جای اینکه به زور یک روش تکراری سؤال کردن را در مصاحبه دنبال کنید، اجازه دهید مسیر مصاحبه تغییر کند و از زاویه دیگری به مشکل نزدیک شوید.

11. روابط دوگانه؟

❖ روابط دوگانه یعنی خارج شدن از ارتباط قراردادی با مراجع. زمانی که نقش حرفه ای مشاوره رو داره. نمیشه همزمان نقش دیگه ای ایفا کنه. اصل 6 از اخلاق در مشاوره. و همچنین در گفته میشه که تاکید بر تعهد اولیه، اهمیت مشاوره برای مراجع و اختلاف قدرت بین مشاور و مراجع دلیلی هست که نباید این اتفاق بیافته و در صورت بروز ضرورت ارجاع به وجود میاد.

12. بوجود آمدن تعارض منافع؟

❖ در مورد تعارض منافع صفحه 82 اخلاق رو بخونید.

13. لمس مراجع؟

❖ لمس مراجع از مصادیق رفتار غیر حرفه ای و غیر اخلاقیه و ممنوعه. اگر حالا مراجع همجنس بود از لحاظ رعایت ادب میشه دست داد فقط. صفحه 130 اخلاق خانم حسینیان.

14. مراجعی که با اصرار همسرش اومده چکار کنیم؟

❖ مراجعی که با همسرش اومده طبق بند خودمختاری از اصول اخلاق حرفه ای در مشاوره باید به مراجع فرصت فکر کردن، بدیم. صفحه 136 اخلاق حرفه ای خانم حسینیان می بینیم که رضایت آگاهانه و ازادانه از حقوق مراجعه.

15. رعایت صداقت؟

❖ رعایت صداقت در همه موارد باید اتفاق بیافته. باید هر اونچه مربوط به اون هست طینی از صداقت باشه.

16. تعارض بین ضوابط اخلاق حرفه ای و مقررات سازمانی؟

در بحث تعارض اخلاق حرفه ای و قانون طبق بند 2-10 باید قانون رو انتخاب کرد. و در صورت وجوب انتخاب اخلاق حرفه ای باید با وکیل مشورت کرد. چون تمام مسئولیتش با مشاور هس. ولی بین اخلاق و مقررات سازمانی، باید طبق ضوابط اخلاق حرفه ای پیش بره.



17. چالش و تعارض اخلاقی؟

❖ در چالش ها و تعارض های اخلاقی اگر به جواب نرسیدیم باید از مقالات بهداشت روانی کمک گرفت تا از جنبه های مختلف مشاور قضیه رو ببینه. و اینکه می تونه با همکاران مشورت کنه.

18. استفاده از استعاره و روایت پردازی در جلسه؟

❖ این یکی از راهبردهای مشاور در جهت پیشبرد فهم مفاهیم درمان است و می تواند به درمان مراجع کمک کند. استعاره بهتر است متناسب با مشکل و بافت زندگی مراجع باشد.

19. ترغیب مراجع به روش جایگزین؟

❖ در مورد ترغیب مراجع به روش جایگزین از اصل دوم؛ سودمندی از اصول اخلاق حرفه ای در مشاوره دیدیم که نباید وادار به پذیرش کنیم. بلکه نقشه ی راهبردی معرفی کنیم. درمانگر هم باید مطمئن باشه از این انتخاب.

20. روش مداخله آیا برای همه یکسانه یا با هر مراجعی دستورالعمل را انطباق می دیم؟

❖ در مورد روش مداخله یکسان. ما باید بگیریم که کیفیت باید برای همه مساوی باشه. طبق صفحه 73 اخلاق حرفه ای. ولی با توجه به تفاوت های فردی و موقعیت های متفاوت شیوه های مداخله هم متفاوت می شه.

21. سازمان نظام دولتی یا غیر دولتی؟

❖ سازمان نظام روان شناسی غیر دولتی. و مستقل.

22. تعداد روان شناس و مشاور در شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره؟

❖ در شورای مرکزی؛ 6 روان شناس. 5 مشاوره. یه نماینده وزیر علوم. یه نماینده وزیر بهداشت.

23. الان چندمین دوره انتخاباته سازمان نظام هستیم؟

❖ پنجمین دوره الان.

24. انتخابات هر چند سال یکبار؟

❖ توسط شورای مرکزی 4 سال یه بار هس. با حکم رئیس جمهور ریاست نظام انتخاب میشه و یا عزل میشه. تکرارش هم در دو دور متوالی امکان پذیره.

25. نظارت بر روان درمانی روانپزشکان به عهده کیست یا چه سازمانی است؟

26. نظام پزشکی. در صورت فعالیت بدون مجوز هم، به نظام پزشکی باید مراجعه شود.

27. کدام وزارت خانه در سازمان نظام حضور دارد؟

❖ وزارت علوم و وزارت بهداشت.

28. در مورد پوشش و ظاهر روان شناس؟

❖ هالندر، سال 1994 می گفت: "جامه یا تن پوش آدم ها، می تونه متقاعد کننده، تداعی کننده، حتی القا کننده و یا اصلا دروغ بگه در واقع یعنی خیلی ظریف، در حالی که پوشنده اون لباس، رک و صریح در مورد مسائل حرف میزنه، ولی لباسش جور دیگه صحبت می کنه".

<https://doi.org/10.53841/bpscpf.2013.1.249.43>

کارلتون میگه: "لباس درمانگر و چیدمان اتاق درمان، بر ادراک مراجعین اثرگذاره. اصن اینطوری بگیم که جذابیت، تخصص و قابل اعتماد بودن درمانگر رو تو همون مصاحبه اول میشه فهمید." کارلتون سال 1984 اومد به آزمایش ترتیب داد. چی بود؟ خب اومد، 233 دانشجوی کارشناسی، آورد. اینا داشتن تصویری در قالب اسلاید مشخص، از یه درمانگر مرد، تماشا می کردن؛ اینجوری که، لباس (رسمی با کت و کراوات در مقابل پیراهن ورزشی) و چیدمان (صندلی، پشت میز در مقابل چیدمان بدون میز). بعدم، آزمودنی ها به یه بخش مصاحبه صوتی گوش دادن. نتیجه این بود: اثرات قابل توجهی برای لباس درمانگر و نوع چینش میز و صندلی و جنسیت، ظاهر شد. لباسای درمانگر و چیدمان صندلی ها، با تمایل به دیدن این درمانگر برای مشاوره، ارتباط زیادی داش.

DOI:10.1002/1097-4679(198401)40:1<52::AID-JCLP2270400109>3.0.CO;2-6

کامیلا نیکولز سال 2014 راجع به لباس درمانگر چنین گفت که؛ "اونچه که می پوشیم، کلی چیز راجع بهمون می گه. می تونه، روی نحوه دید مردم و مراجعین، اثر بزاره. روی اعتمادشون و روی میزان آمادگیشون برای ارتباط درمانی و برون ریزی، اثر بذاره." پیتر هابسون، می گه: "همیشه برای ملاقات با مراجع، باید اعتراف نمادین به این موضوع باشه که هرچقدر صمیمی، باز هم این ملاقات، چارچوب رسمی داره. یعنی نقش روان شناس، یه درمانگر حرفه ایه، نه یه دوست." نیکولز می گه: "مراجع باید احساس کنه که تحت درمان فردیه که آموزش دیده و واجد شرایط رسیدگی به احساساتش _مانند: افسردگی، اضطراب، غم و اندوه_ هست. درمانگر، مدل مجله ی ووگ Vogue نیس. فروید می گفت: "گاهی سیگار برگ فقط یه سیگاره، اما به نظر می رسه که ژاکت روان درمانگر، به ندرت فقط یه ژاکت خالیه".

خب حالا چی پوشیم؟

دکتر Phoenix میگه: "کد لباس پوشیدن خاصی واسه یه روان شناس وجود نداره". مؤسسه اکسیر، غیر مستقیم راجع بهش حرف زده.

به علاوه در قوانین نظام، گفته بود؛ متناسب با شئون و متناسب با سن و عرف باید بود. می‌دونید این نظام نامه خیلی چیزها رو پوشش نداده خب. میلر سال 1990 گفته: "پوشش و ظاهر باید حرفه ای باشه". کتاب خانواده ی "پست" در مورد ظاهر در محل کار می‌گن: "لباس مناسب بپوشید. مهم نیس خودمون، تو آینه چطوری خودمون رو می‌بینیم. مهم اینه که دیگران چطور مارو می‌بینن." یعنی مهم اینه که در نظر مراجع چطور به نظر میایم. و مطلب دیگه اینکه توجه ها به لباس ما جلب میشه یا توانایی های ما. لذا آنچه از مقالات و رفرنس های مختلف به دست اومد. پوشش مشاور کد لباس خاصی ندارد. باید متناسب با شئون، عرف، سن، رد فلگ های درمانگر، مرزهای اتاق درمان باشد.

پوشش و ظاهر شما هم به مراجع می‌تونه به مراجع پیام برسونه. پس به گونه ای باشه که همسو با موارد بالا باشه تا متناقض رفتار نشه. و مراجع را از برون ریزی و ایجاد رابطه درمانی سالم، منحرف نکنه.

29. از نظر شما مشاور خوب کیست؟

❖ مشاور خوب ص 22 خلاصه گلدارد نوشته.

30. درخواست شماره تلفن مشاور برای چه موردی مجاز است؟

❖ در موقعیت های بحرانی مثل مراجع خودکشی گرا یا افسردگی شدید. در موارد دیگه شماره ی منشی و دفتر کفایت می‌کنه.

31. سوگیری چگونه؟

❖ سوگیری به معنای انحراف حقیقت هست که انواع مختلفی داره. که زیاده. اگر خواستین بزارم.

32. استرس و اضطراب خودتو چطور مدیریت کردی، چی بگیم؟

❖ در طول اعلام زمان و مکان آزمون، خیلی از متقاضیان با استرس و اضطراب شدید مواجه هستن که ممکنه منجر به ایجاد

اختلالات خواب و کاهش تغذیه بشه. خب می‌تونه بر عملکرد ذهنی و فیزیکی هم تاثیر بذاره. یا باعث کاهش تمرکز و اختلال در حافظه، در وقت اصلی مصاحبه بشه؛ که مدیریت این هیجانات حیاتیته.

مغز ما هم در شرایط استرس زا نمی‌تونه به طور موثری اطلاعات رو از حافظه بلندمدت دریافت کنه و به سؤالات پاسخ بده. بنابراین، مدیریت استرس و آماده‌سازی روانی برای زمان مصاحبه قاعدتا خیلی مهمه.

تکنیک هایی که برای مدیریت این اضطراب میشه استفاده کرد؛ خواب و تغذیه مناسب قبل آزمون، تحرک و پیاده روی قبل از آزمون، تکنیک نوشتن افکار یا بارش فکری، پرهیز از کمال گرایی، اختصاص زمانی برای افکار مزاحم و نگرانی ها، چوب خط زدن برافکار مزاحم، آگاهی از مباحث غیرمنطقی و خودگویه های منفی سپس جایگزین کردنشان با باوری متعادل،

تصویرسازی و تجسم مثبت از خود، تکنیک تنفس، ریلکسیشن، مراقبه همراه با موزیک های بی کلامش در جهت آرام سازی ذهن و افزایش تمرکز...

33. چند مهارت سی بی تی؟

❖ خب CBT کمک می کنه که مراجع به درک بهتری از مسئله ای که باعث عدم تعادل روانی در اون شده، برسه. یعنی اون مسئله رو به اجزای کوچک تر تقسیم می کنه و خب این میشه که مراجع تاثیر این معضل رو بر زندگیش ببینه. مفهوم شناخت (اطلاعاتی که در ذهنه) و هیجان (که شامل اون احساس هایی میشه که هر کسی تجربه می کنه) و رفتار (که واکنش به محرکه. یه محرک درونی و بیرونی هست و بعد باعث یه رفتار میشه)؛ این رویکرد با بازنمایی اطلاعات در ذهن، باورهای بنیادی، افکار خودایند کارآمد و ناکارآمد، کاربست تکنیک پیکان رو به پایین، تکنیک تحلیل مزایا و معایب، تکنیک بررسی شواهد (توضیح شواهد تایید کننده و رد کننده ی فکر مورد نظر)، تکنیک ایفای نقش وکیل مدافع (هدفش دفاع از مراجع در مقابل افکار منفی و قضاوت هاست و برای اینکه مراجع احساسات مثبت رو تجربه کنه، راهش اینه که با اون احساس هایی که ازش فرار می کنه روبرو بشه. و بیاد ازش حرف بزنه. درجه گذاری میزان تجربه ی احساس رو داریم در موقعیت مورد نظر. که مثلا در فویباها تکنیک حساسیت زدایی منظم و غرقه سازی و... داریم...

شناخت چرخه معیوب در معضل مربوطه

مراجع با انتخاب رفتارهایی که می تونه به بهتر شدن نوع افکار کمک کنه. اینجا باید رفتار مراجع تغییر کنه. با یادآوری ارزش و احقاق آن ها، مراجع بگه با چه رفتاری و چگونه می تونه اون هارو دنبال کنه. و اینکه دوس داره دیگران چطور مطابقش عمل کنند. تکنیک DTR، بازیابی نگرانی ها و تعیین وقت مخصوص نگرانی، تکنیک ERP، یادآوری چگونگی مقابله ی موثر با افکار گذشته، تکنیک ماشین زمان و...

34. چند مهارت اکت؟

❖ اجزای ACT شامل "پذیرش"، "انتخاب مسیرها" و "اقدام" می شه. تراپیست باید با دانش خودش در انتخاب و اجرای مراحل درمان مثل: تمرینات مجهز باشد.

باید تکنیک هارو خلاقانه و منعطف به کار ببره، پذیرش و تمایل رو به صورت عملی به مراجع نشون بده. تجربه اونچه که در فکر و احساس مراجعه، همانطور که هست؛ و نه اینکه تراپیست تفسیر و اصلاحش کنه. تمرکز بر تجربه مراجع باشه، پرهیز از بحث یا تلاش برای متقاعد کردن مراجع اتفاق بیافته و همچنین پرهیز از توضیح و شفاف سازی مسائل به مراجع. حتی اگر تراپیست فک کنه که، اینکه گاهی تجربه شخصی خودشو بگه، به درمان کمک می کنه، بگه. اشکالی نداره. واکنش های مراجع مهمه. در نهایت این رویکرد می خواد یه زندگی ارزشمند برای مراجع رقم بزنه.

35. تعارض منافع چیست؟

❖ یعنی (Conflict of interest)، تقابل دو تا مسئله ی منفعت آمیزی که هر کدام، مشخص و تعریف شده اند پس سخته یا حتی نمی شه یکی رو بر دیگری ارجحیت داد. مثلا مقابل هم قرار گرفتن منفعت حرفه ای و منفعت شخصی، که انتخاب یکی از اونها شخص رو به چالش می کشه.

36. تصدیق نامه در پژوهش چیست؟

❖ تصدیق نامه همان گواهی تایید علمی پژوهش هستش. که از طرف نهاد علمی مورد نظر به پژوهشگر داده می شود.

37. ویژگی لازم برای مشاور؟

❖ 1. سازماندهی گروه (یعنی ابتکار برای هماهنگی یه عده ادم) بلد باشه. 2. بلد باشه برای حل مسئله مذاکره کنه (میانجی گری و جلوگیری از بروز اختلاف و حل مشکلات بدونه) 3. کسی که روابط شخصیش خوب باشه (یعنی استعداد همدردی و دلجویی از دیگران داشته باشه و احساس مسئولیت در قبال آدم ها داشته باشه. بلد باشه یه رابطه بسازه). 4. تجزیه و تحلیل اجتماعی بدونه (یعنی شناخت راجع به عواطف، انگیزه و علایق دیگران داشته باشه). آدمی با این ویژگی ها صاحب هوش بین فردی میشه قاعدتا خب طبیعتا راحتتر می تونن رابطه صمیمی بسازن با بقیه. با این تواناییشون، می تونند مشاور یا روان درمانگر خوبی بشن.

38. در مقابل تقاضای دست دادن مراجع چه باید کرد؟

❖ این سؤال که در مبحث Physical boundaries قرار می گیره که هر تراپیستی باید یه فضای خصوصی و دستورالعملی روشن برای خودش به مراجعش ارائه بده.

حالا اون طرفی ها می گن: مثلا "I'm not a hugger"

یا

"I'm tired, and I need to rest before we go to dinner"

یا

"It's not OK for you to touch me in that way"

در واقع با این مرزها، نشون می دین این قوانین حرفه ای شما در اتاق درمان شماسه. و خب خیلی موارد در انتخاب شما دخیله.

39. به نظر شما کدام یک از موارد زیر، سهم بیشتری در فرسودگی روانی روان شناسان یا مشاوران دارد؟

(1) مواجهه و درگیری با مسائل عاطفی و هیجانی مراجعان در روند کار.

(2) سطح بالای خطرات جانی در کار آن ها.

(3) ضرورت حفظ مرزهای ارتباطی در شغل ایشان.

4) رعایت و توجه به موازین اخلاق حرفه ای در شغل این افراد.

❖ گزینه اول.

40. نظر شما در مورد بلند شدن روان شناس یا مشاور به هنگام ورود مراجع به اتاق کار وی چیست؟

- 1) این رفتار تنها برای مراجعینی سودمند است که از لحاظ سنی بزرگ تر از روان شناس یا مشاور هستند.
- 2) این رفتار برای دریافت احترام از سوی مشاور یا روان شناس سودمند است.
- 3) این رفتار شکل رسمی به جلسه می دهد؛ و راحتی و امنیت مراجع را تهدید می کند.
- 4) این رفتار در واقع شکلی از انتقال متقابل است؛ و تمام آثار انتقال متقابل را شامل می شود.

❖ گزینه دوم.

41. کدام گزاره در مورد محرمانه بودن اسرار مراجع صحیح تر است؟

- 1) تنها در صورتی که مراجع به شکل صریح، موافقت خود را اعلام کند؛ اسرار او را با دیگران به اشتراک می گذارم.
- 2) کاملاً به رعایت محرمانه بودن اسرار مراجع، مطابق با دستورالعمل های حرفه ای مقید هستم.
- 3) اسرار و اطلاعات مراجع را تنها در دوره های آموزشی با متخصصان و با همکاران متخصص در میان می گذارم.
- 4) مسئولیت من در مورد اسرار مراجع، تنها به رعایت موارد ایمنی در نگهداری محرمانه ی اطلاعات محدود می شود.

❖ گزینه دوم.

42. شما در مورد مسئله ی مرزهای بین روان شناس و مشاور با مراجع، کدام یک از موارد زیر را مناسب تر می دانید؟

- 1) بر این باور هستم که محو کردن مرزهای ارتباطی به نفع مراجع است و ارتباط و اتحاد را تسهیل می کند.
- 2) حفظ مرزهای ارتباطی مشاور با مراجع کاملاً بستگی به شرایط مراجع و رضایت آگاهانه ی او دارد.
- 3) اگر ارتباط با مراجع به نفع او باشد؛ گاهی خارج از چهارچوب مشاوره با او ارتباط های سالمی برقرار می کنم.
- 4) در تمام موارد مرزهای مشخصی را با مراجع حفظ می کنم و تنها در چهارچوب حرفه ای با مراجع ارتباط دارم.

❖ گزینه چهارم.

43. کدام یک از موارد زیر انتخاب مناسب تری در مورد مفهوم رضایت آگاهانه مراجعان است؟

- 1) اطمینان می یابم که مراجع نسبت به فرآیند، هدف، سودمندی ها و تهدیدهای احتمالی مداخله آگاه است.
- 2) این مسئله که مراجع بالغ و بزرگسال، خود برای مداخله مراجعه کرده است؛ نمایانگر رضایت آگاهانه ی او است.
- 3) سعی می کنم اطلاعات کمی در مورد فرایند مداخله به مراجع ارائه دهم؛ تا دغدغه های ذهنی او را زیاد نکنم.
- 4) رضایت آگاهانه در مورد مداخلاتی که کاملاً پشتوانه ی علمی دارند؛ و به نفع مراجع هستند؛ ضرورتی ندارد.

❖ گزینه اول.

44. در مورد پدیده ی روابط دوگانه (Dual Relationships) با مراجعان کدام مورد مناسب تر است؟

- 1) پیش از درگیر شدن در رابطه‌ای خارج از چارچوب مداخله، رضایت آگاهانه ی مراجع را کسب می‌کنم.
- 2) روابط دوگانه گاهی به نفع مراجع است؛ و روند اثرگذاری را تسهیل می‌کند.
- 3) از هرگونه روابط دوگانه با مراجعان، به جهت رعایت منافع ایشان اجتناب می‌کنم.
- 4) تا زمانی که مشاوره و مداخله پایان نیابد؛ وارد ارتباط دیگری با مراجع نمی‌شوم.

❖ گزینه سوم. همون توضیحات روابط دوگانه در سؤال 11.

45. در مورد بروز احساسات عاطفی مراجع نسبت به شما، به کدام یک از گزاره‌های زیر اعتقاد دارید؟

- 1) این احساس را واقعیتی در مسیر شناخت مراجع در نظر می‌گیرم؛ اما وارد آن نشده و آن را مهار می‌کنم.
- 2) تنها در صورتی که نسبت به مراجع احساس مشابهی داشته باشم؛ به احساس او پاسخ می‌دهم.
- 3) سعی می‌کنم این مسئله را با نهادهای نظارت اخلاقی مطرح کنم و از پذیرش مراجع اجتناب می‌کنم.
- 4) به مراجع تذکر می‌دهم که در صورت توافق، این احساس را باید تنها در خارج از فضای مشاوره دنبال کنیم.

❖ گزینه اول.

در مورد ابراز احساسات مراجع میشه قسمت وابستگی خلاصه گلدارد ص 17 رو بخونید و بند 6-3 هم نگاه کنید.

➡ مراجع به چند دلیل به مشاور وابسته می‌شه: اول اینکه رابطه مشاوره ای در ماهیت خودش صمیمیت، گرمی و پذیرش دارد و این خود به نوعی دوستی دامن می‌زند. دوم اینکه مراجعان خصوصی ترین رازهایشان را به مشاوران می‌گویند و همین طرح موضوعات محرمانه باعث نوعی نزدیکی، اعتماد و حتی انتظار برای رابطه بلند مدت ایجاد می‌کند. سوم اینکه بسیاری از مراجعان، انسان های تنها و حتی رانده شده ای هستند که، جریان مشاوره نوعی پناهگاه امن برایشان محسوب می‌شود و این کاملاً بدیهی است که در حالت افسردگی، اضطراب یا تنهایی بیشتر به دیگران وابسته شویم. و چهارم اینکه مشاور دارای موقعیت اجتماعی نسبتاً بالایی در جوامع برخوردار است. دارا بودن تحصیلات بالا، دیدگاه مثبت نسبت به این حرفه و نوع ارتباط همگی در وابسته شدن مراجع موثر است.

از سوی دیگر وابستگی در جلسه مشاوره می‌تواند متقابل باشد. مشاوران انسان های ماشینی بی احساس نیستند بلکه با احساس و نیازهایشان زندگی می‌کنند. بنابراین مشاوران باید آگاه باشند که صرفاً برای ارضای نیازهای شخصی خود، مراجع را تشویق به ادامه جلسات نکنند، هنگام بروز وابستگی، مساله را بروز دهند و اعلام کنند که نسبت به آنچه در جریان است آگاهند و هرگز درگیر رابطه خارج از حوزه جلسات مشاوره نشوند. حالا اینم بگیم که کلاً انتقال که بهش نوروز انتقال میگن. یعنی انتقال احساسات و عواطف مثبت و منفی مراجع در خصوص افراد مهم زندگیش به مشاور. در چنین وضعیتی مراجع فراتر از بیان مشکل و طلب کمک تخصصی تمامی احساسات، حالات و جنبه های دردناک عاطفی خودشو به مشاور منتقل و به

نوعی مشاور رو با نروز های خودش درگیر می کنه. حالا اگه درمانگر ناآگاه باشه یا آماده نباشه، خب تصور می کنه که اونو یه انسان ویژه و برتر برگزیده دیدن با حس های مثل عشق، نفرت، هدیه دادن و... یا با اون خصومت شخصی دارن.

46. در موقعیتی که مراجع از تهدید در مورد آسیب به خود یا دیگری صحبت می کند؛ چه واکنشی مناسب تر است؟

- 1) این کار به معنای جلب توجه من است؛ و یعنی اینکه مراجع نتوانسته به شیوه مطلوبی نظر من را جلب کند.
- 2) اقداماتی را که برای حفظ مراجع یا دیگران در برابر آسیب لازم است؛ حتی با نقض اصل محرمانگی پی می گیرم.
- 3) همچون سایر موارد از اسرار مراجع سوءاستفاده نمی کنم و سعی می کنم، این اطلاعات محرمانه را حفظ کنم.
- 4) دلایل اصلی افشاء چنین چیزی را بررسی می کنم و در مورد اشتباه بودن چنین کاری به او هشدار می دهم.

❖ گزینه دوم.

خب این مصادیق افشاء یا عدم رازداریه. طبق بند سوم. در مورد خودکشی هم اصل 10-1 و 11-1 مطالعه بشه.

47. تصمیم شما در صورت پدید آمدن تعارض منافع (Conflict of Interest) شخصی با منافع مراجع در جریان مشاوره چیست؟

- 1) بدون آن که مراجع را درگیر و آگاه کنم، بر اساس قضاوت خود، تعارض منافع را مدیریت می کنم.
- 2) از رویارویی و تفکر در مورد هر موقعیتی که تعارض بین مراجع و من را آشکار سازد؛ اجتناب می کنم.
- 3) وقتی با تعارض منافع در جریان مداخله روان شناختی مواجه شوم از گفتن آن به مراجع اجتناب می کنم.
- 4) تعارض منافع پیش آمده را برای مراجع توضیح داده و کاملاً به نفع شخصی او احترام می گذارم.

❖ گزینه دوم. طبق بند 5-3 باید از پذیرش نقش حرفه ای در این موقعیت اجتناب کرد. گزینه دو. و طبق بند 5-6 حتی الامکان

واردش نباید شد وگرنه پذیرش منافع شخصی در جهت منافع مراجع.

48. مراجعی از شما می خواهد که یک کپی کامل از پرونده مشاوره را در اختیار او قرار دهید، تصمیم شما چیست؟

- 1) او را به معاونت انتظامی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ارجاع می دهم که از آنجا نامه بگیرد.
- 2) با توجه به اینکه این درخواست حق مراجع است، کپی کامل را به او می دهم.
- 3) برای حفظ محرمانگی و حریم تخصصی ارائه کپی کامل پرونده را نمی پذیرم.
- 4) این اطلاعات را به او می دهم، اما حتماً از او تعهد می گیرم که برای چه منظوری استفاده کند.

❖ گزینه چهارم.

49. وقتی مراجع بزرگسالی در مورد سوءاستفاده یا آسیب گذشته و یا کنونی گزارش می دهد؛ چه می کنید؟

- 1) رسیدگی به این نوع مسائل به سازمان نظام روان شناسی و مشاوره مربوط است؛ و سعی می کنم که دخالتی نکنم.
- 2) ضمن همدلی و همراهی با مراجع، به عنوان متخصص مسئول، فرد سوءاستفاده گر را فرا می خوانم.
- 3) سعی می کنم برای کاهش آسیب، اهمیت آن را کم رنگ کنم و ظرفیت تاب آوری او را افزایش دهم.

4) سعی می‌کنم با دادن امنیت و همراهی با وی، رضایت او را برای گزارش به مراجع مربوطه ترغیب کنم.

❖ گزینه چهارم.

50. تتل اگر فرد همجنس‌گرایی برای دریافت خدمات حرفه‌ای به شما مراجعه کند. چه برخوردی می‌کنید؟

- 1) ضمن پذیرش وی، اطلاعات او را به صورت محرمانه به سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره می‌دهم.
- 2) کمک‌های حرفه‌ای مناسب را به او ارائه می‌دهم.
- 3) او را به عنوان مراجع نمی‌پذیرم و خدماتی به او ارائه نمی‌دهم.
- 4) ضمن پذیرش وی، اطلاعات او را به صورت محرمانه در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌دهم.

❖ گزینه دوم.

51. چه نظری در مورد تبلیغ قابلیت‌های خود به عنوان یک مشاور یا درمانگر دارید؟

- 1) فعالانه در مورد قابلیت‌های خودم تبلیغ می‌کنم تا اثر خوبی روی مراجعین داشته باشم.
 - 2) تبلیغ در مورد خودم را به مؤسسات بازاریابی محول می‌کنم.
 - 3) صرفاً به معرفی خود و خدماتی که ارائه می‌دهم بسنده می‌کنم.
 - 4) حرفه‌ی من فعالیت علمی است و هیچ نیازی به معرفی و تبلیغ ندارد.
- ❖ گزینه سوم. در مورد تبلیغات بند 1-9 مربوط به تبلیغات و خدمات عمومی؛ باید از هرگونه اظهار کذب و جعلی اجتناب کرد و منطبق بر کدهای اخلاقی عمل کنن.

52. نظر شما در مواردی که مراجع نیاز به دارو دارد و یا خود درخواست دارو می‌کند، چیست؟

- 1) در موارد نیاز به دارو، مراجع را ارجاع می‌دهم.
- 2) ابتدا در مورد اثر دارو و عوارض آن بررسی کامل می‌کنم؛ و با احتیاط کامل دارو تجویز می‌کنم.
- 3) صرفاً داروهایی را که فروش آن‌ها آزاد است و عوارض جانبی چندانی ندارند، توصیه می‌کنم.
- 4) در کنار داروهای ضعیفی که معرفی می‌کنم؛ تاکید را بر روان‌درمانی می‌گذارم.

❖ گزینه اول.

53. استفاده روان‌شناس یا مشاور از تفکر انتقادی دربرگیرنده کدام یک از موارد زیر است؟

- 1) انتقاد و تقابل عاقلانه با آنچه مراجع مطرح می‌کند.
- 2) اتکای به تجارب بالینی و نادیده گرفتن دیدگاه‌های جایگزین.
- 3) برخورد شهودی و مبتنی بر دانش شهودی در برابر مسائل.
- 4) سنجش شواهد و در نظر گرفتن دیدگاه‌های متفاوت.

❖ گزینه چهارم.

54. نظر شما در مورد کاربرد لمس در جریان مشاوره و روان‌درمانی چیست؟

- (1) استفاده از لمس تنها برای برقراری اعتماد و اتحاد درمانی مجاز است.
- (2) تنها در شرایطی که از تکنیک‌های تن‌آرامی (Relaxation) استفاده می‌کنم؛ از لمس بهره می‌برم.
- (3) تنها در شرایطی که از هیپنوتراپی استفاده می‌کنم؛ لمس محدود مراجع را استفاده می‌کنم.
- (4) برای حفظ مرزهای مشاور و مراجع، از لمس در جریان مداخله استفاده نمی‌کنم.

❖ گزینه چهارم.

لمس در اتاق درمان رو بالا گفتیم. و اضافه بر اون بگیم که طبق بند 3-6 هم گفته که باید از سوءاستفاده از رابطه درمانی اجتناب کرد.

55. اگر در جریان کار با مراجع، متوجه شوید، نوعی سوگیری (Bias) نسبت به او دارید؛ چه می‌کنید؟

- (1) برای اجتناب از تعارض یا ناراحتی مراجع، سعی می‌کنم به این سوگیری توجه نکنم.
- (2) این مورد را با یک مشاور یا روان‌شناس ارشد راهنما مطرح می‌کنم تا جریان سوگیری را مدیریت کنم.
- (3) برای احترام به حقوق مراجع، این سوگیری را منصفانه مطرح، و در مورد آن با مراجع صحبت می‌کنم.
- (4) خودم این مسئله را مدیریت می‌کنم و در این مورد نیز مانند مراجعان دیگر منصفانه عمل می‌کنم.

❖ گزینه دوم.

56. در صورتی که قاضی اطلاعاتی از شما در مورد سوابق مراجع، بخواهد؛ چه می‌کنید؟

- (1) نسخه‌ای از پرونده‌ی مراجع را در اختیار قاضی و معاونت انتظامی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره قرار می‌دهم.
- (2) برای حفظ محرمانگی اطلاعات مراجع، از دادن سوابق خودداری می‌کنم.
- (3) صرفاً خلاصه‌ای از مداخلات را با رعایت ضوابط اخلاقی، در اختیار قاضی قرار می‌دهم.
- (4) برای تعهدی که نسبت به مراجع دارم؛ اطلاعات را به گونه‌ای می‌دهم؛ که به نفع مراجع باشد.

❖ گزینه سوم.

طبق بند سوم از مصادیق افشاء هست و اون قسمت مورد نظر رو در اختیارش می‌زاریم با رعایت منافع مراجع و جلوگیری از سوء استفاده از نتایج آزمون.

57. وقتی مراجعی راجع به شیوه‌ی به کار گرفته شده‌ی شما، در مداخله، تردید یا نگرانی دارد؛ چه می‌کنید؟

- (1) شواهد علمی و پشتوانه‌های نظری را برای تردید او در مورد روایی روش مورد استفاده، مطرح می‌کنم.
- (2) به او اطمینان می‌دهم که در کار خود توانمند، و دارای مهارت هستم.

3) محترمانه از او درخواست می‌کنم؛ که در مقوله‌های تخصصی دخالت نکند.

4) با وی گفتگوی صادقانه ای می‌کنم؛ و نگرانی‌های او را مورد توجه قرار می‌دهم.

❖ گزینه چهارم.

58. در صورتی که متوجه می‌شوید فردی با اصرار همسرش به شما مراجعه نموده است؛ چه واکنشی نشان می‌دهید؟

1) از پذیرش او اجتناب می‌کنم و مطمئن هستم که مداخله برای او سودمند نیست.

2) پیش از اینکه جریان مشاوره را آغاز کنم؛ به او اختیار می‌دهم که در مورد ادامه کار تصمیم بگیرد.

3) پیش از اینکه جریان مشاوره را آغاز کنم؛ می‌خواهم که همسرش با من جلسه‌ای داشته باشد.

4) او را پذیرش می‌کنم و به او اطمینان می‌دهم که فرایند مداخله برای وی سودمند است.

❖ گزینه دوم.

همون توضیحات سؤال 14. باید طبق بند 8-3 توافق آگاهانه با رعایت خودمختاری مراجع صورت بگیره. وگرنه طبق بند 9-3 با قیم مراجع.

59. کدام گزاره درخصوص اصول اخلاقی و استاندارد‌های حرفه‌ای مناسب‌تر است؟

1) می‌توان برای پیشرفت و بهبودی مراجع گاهی از آن‌ها تخطی کرد.

2) باید در وهله اول به خواست و رعایت حال مراجع توجه کرد و این موارد را در جهت این خواست تغییر داد.

3) این موارد انعطاف‌پذیر هستند و می‌توان تفسیرهای متفاوتی از آن‌ها داشت.

4) این موارد تصمیم‌گیری و روش مورد استفاده من را هدایت می‌کنند.

❖ گزینه چهارم.

60. وقتی مراجعی به صورت مستقیم راجع به پختگی سنی یا کفایت تجربه شما سؤال می‌کند؛ چه می‌کنید؟

1) اطلاعات صادقانه و روشنی در مورد سن و تجربه خود به او می‌دهم.

2) با احترام به او توضیح می‌دهم که بایستی مرزهای شخصی را حفظ کند و به این مسائل نپردازد.

3) ابتدا دلیل این پرسش را از او می‌پرسم و به او اطمینان می‌دهم که در کار خود خبره هستم.

4) برای حفظ اقتدار درمانی و کمک به وی، خود را توانمند و باکفایت معرفی می‌کنم.

❖ گزینه اول.

صادقانه و روشن در مورد سن و تجربه می‌گوییم. این آگاهی دادن از حقوق مراجعه.

61. در برخورد با مراجعان رعایت صداقت تا چه حد اهمیت دارد؟

1) اگر در همه موارد با او صادق باشم. عملی کردن برخی تصمیم‌ها برای او دشوار می‌شود.

(2) همیشه باید با مراجع صادق باشم.

(3) مهم‌تر از صداقت، حفظ خوشحالی مراجع است.

(4) برای من حفظ منافع مراجع، مهم‌تر از صداقت با او است.

❖ گزینه دوم.

همان سؤال 15 ام است.

62. به نظر شما کدام گزاره در مورد استفاده‌های پژوهشی از مراجعان مناسب‌تر است؟

(1) اگر استفاده از آزمون‌ها صرفاً برای اهداف پژوهشی باشد؛ می‌توان از مراجعان استفاده کرد.

(2) با توجه به اهمیت روایی درونی، نباید مراجعان را در جریان هدف پژوهشی اجرای آزمون‌ها قرار داد.

(3) استفاده از مراجعان برای اهداف پژوهشی باید بر مبنای موافقت آن‌ها و ارائه پاداش به آنان باشد.

(4) برای استفاده از مراجعان در تکمیل آزمون‌ها؛ باید آن‌ها را بخشی از فرایند مشاوره آنان قرار داد.

❖ گزینه سوم.

طبق بند 2-3 باید از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری کنه.

63. مدت زمان انتخابات سازمان؟

❖ مدت زمان انتخابات 4 ساله.

64. سازمان خصوصی دولتی یا نیمه دولتی؟

❖ سازمان غیر دولتی.

65. حکم رئیس سازمان را چه کسی امضا می کند؟

❖ حکم رو رئیس جمهور امضا می کنه.

66. کدام ارگان ها در شورای مرکزی نماینده دارند؟

❖ وزارت بهداشت و وزارت علوم نماینده دارن.

67. چه زمان باید پرونده پایگانی شود؟

❖ حداقل 5 سال پس از پایان درمان و برای کودکان تا رسیدن به سن قانونی ص 97 اخلاق حرفه ای.

68. سازمان نظام روان شناسی تحت نظر کجاست؟

❖ زیر نظر وزارت علوم و وزارت بهداشت. هر کدام به نماینده در شورای مرکزی دارند.

69. اگر حال مراجع در جلسه مشاوره خیلی پریشان شد؛ چه کار می کنید؟

❖ حال پریشان مراجع. طبق اوتمر؛ ارزیابی رنج و ناراحتی رو با سؤالای باز مثل: چي ناراحت کرده؟ (در مورد مود و افکت می فهمیم) و پیرسیم مثلا احساسات در مورد چیه؟ (علاقمندی به احساس بیمار رو نشون می دیم) این پریشونی اگه گریه باشه. دستمال باید روی میز در دسترس باشه. بهش فرصت میدیم که گریه کنه و حرفشو بزنه. که در این موقعیت بهتره که با "زبان بدن" و "صدای ملایم" باهاش هماهنگ شد و "همدلی" کرد. یا کلمات همدلانه ی کوتاه. بعد اینکه ممکنه که با فریاد گریه کنه. و نیاز به بروز هیجان داشت بهش آموزش بدیم که این هیجانات دائمی نیس و گذرا هستن.

70. اگر مراجع در حین جلسه خواستار تغییر رویکرد شد چه می کنید؟

❖ خواست وسط کار رویکرد عوض کنه؛ این ناهماهنگی بین انتظارات مراجع و اهداف درمانه. خب اینو در نظر بگیریم که حقشه سؤال کنه و پاسخ های قابل درک بگیره. پس اولش یه پیمان مشاوره ای با توافق طرفین بزاریم. در این مورد خلاصه گلدارد نکته 74 بخونید.

71. اگر مراجع ناسزا گفت؛ شما چه می کنید؟

❖ در مورد ناسزا: اول حالت بدنی منفعل و غیر تهاجمی گرفت. خونسرد بود و با نفس عمیق و پذیرفتن نگرانی هاش با گوش دادن فعال این باور رو بهش بدیم که درک می شه. و کلیشه ای این کار رو نکنیم. پرسش های باز Open_ended مطرح کنیم. که جوابای طولانی تری دارن و پاسخ طولانی میدن مراجع. حتی اگر مارو سرزنش کرد حتی شده عذرخواهی کنیم که چنین حسی بهش دادیم و همدلی کرد. اگه گف مشاور جذابی نیسی. عصبانی نشو. گوش کن یا حتی پیرس چرا اینطور فکر می کنی؟ این نه تنها تنش رو کم می کنه بلکه به درمان هم کمک می کنه. در صورت حرفه ای نبودن این میدان جنگ خواهد بود و نه درمان. تا جایی که مراجع اطمینان حاصل کنه که متوجه نگرانی هاش شدیم. و در آخر علاوه بر شفقت به مراجع ابراز کنیم که  تهدید یا فحش یا پول ندادن برای کلینیک و اتاق درمان شما قابل قبول نیس.

72. اگر در مورد روش مداخله اطلاعات خواست؟

❖ بهش آگاهی می دیم.

73. اگر به صورت آنلاین مشاوره خواست؟

❖ در مورد مشاوره آنلاین. با توجه به اینکه متفاوت خواهد بود، در صورتی که در اون مهارت داریم مداخله می کنیم. وگرنه در اونچه که تخصص نداریم ورود نمی کنیم.

74. اگر دانشجویی طرح پژوهشش را در کلینیک ما انجام بدهد؛ اسم چه کسی اول به عنوان پژوهشگر می آید؟

❖ در بخش پژوهش گفته شده که دانشجو مولف اول باشه مگر اینکه نقشی در استخراج مقاله از پایان نامه نداشته باشه.

75. اگر یکی از همکاران، که دانشجوی دکتری است؛ از ما خواست که توصیه نامه برایش بنویسیم چه کنیم؟

❖ توصیه نامه طبق بند 13-7 آموزش کارورزی و نظارت گفته که در چارچوب صلاحیت ها و توانایی های واقعی فرد و بر اساس شناخت شخصی خود این کار را انجام می دن.

76. اگر مراجع، صلاحیت حرفه ای و علمی مشاور را به چالش کشید؟

❖ به چالش کشیدن هم طبق سؤال 60 صادقانه و روشن در مورد تجربه مون پاسخ میدیم بهش.

77. اگر مراجع در جریان مشاوره اطلاعات خصوصی کسی را بیان کرد؛ که ربطی به مشاوره ندارد، برخورد ما چیست؟

❖ اطلاعات خصوصی کس دیگه رو بده یا مراجع خیلی حرف بزنه خب باید مشاور جلسه تحت کنترل بگیره.

78. اگر در فرایند مشاوره و روان درمانی، متوجه اشتباه خودمان شدیم؛ بهترین برخورد چیست؟

❖ اگر متوجه اشتباه خودمون بشیم هم؛ خلاصه گلدارد ص 10. بررسی راه حل ها و کشف گزینه ها. مشاور در زمان ناکامی می

تواند در مورد راه حل صحبت کند و عقیده اش را بگوید و اینطور درماندگی خودش را بگوید که: "امروز به بن بست رسیدیم. بهتره امروز همینجا تمومش کنیم تا وقت دیگه ای راجع بهش صحبت کنیم".

79. اگر مراجع مدام جلساتش را کنسل کند؟

❖ در مورد کنسل کردن مدام دو بحث مطرحه: اول اینکه در ص 168 خانم حسینیان گفته در قرار مشاوره ای میاد که اگر مراجع

قصد لغو داره 48 ساعت قبلش باید اطلاع بده. و بعدش در مورد علت لغو، سؤال بشه از مراجع.

و مطلب دیگه اینکه: هیجانات خودمون رو بخاطرش کنترل کنیم. اگه کنسل کنه یا وقفه طولانی خب راجبش فک می کنیم که ایا به روش تراپی ما برمی گرده یا اینکه مربوط به اتفاقات زندگیشه یا اجتنابه. سؤال می کنیم که علتش چیه؟ و تغییراتی در برنامه درمان ایجاد می کنیم.

80. اگر بخواهیم از مراجعان، در پژوهش استفاده کنیم؟

❖ با رضایت آگاهانه و کتبی باید باشه.

81. اگر ایرانی خارج از کشور بود؟

❖ ایرانی خارج از کشور هم؛ به دلیل زمینه ها و تشابهات فرهنگی ترجیحش مشاور ایرانیه.

82. چه موقع جلسات را خاتمه دهیم؟

❖ زمان مناسب خاتمه جلسه در گلدارد گفته شده که : باید براس حدود 10 الی 15 دقیقه قبل پایان تدارک دید. و گف انقدر دیگه

زمان داریم. مروری کنیم جلسه رو و به مراجع بفهمونیم که مشاور به زمان جلسه آگاه و تحت کنترلشه. دیگه اون موقع انعکاس محتوا یا احساس و طرح سؤال نباید باشه.

83. فرق بین پیش دآوری و تبعیض؟

❖ پیش دآوری شناختیه. تبعیض عمله.

شروع بخش نمونه سؤالات موجود در ویس دکتر محمد ترکمان (زحمت استخراج سؤالات از ویس، بانوان فریده عبدی و غزال جمشیدی):

● (اخلاق حرفه ای)

84. اگر مراجعی بخواهد به همسرش آسیب شدید بزند، کاری که شما باید انجام دهید، چیست؟
- ❖ طبق قسمت نقض اصل رازداری / بند 4_5_2 نظام نامه: یعنی در صورت "وجود خطر جانی برای مراجع یا دیگران"، درمانگر می تواند از اصل رازداری صرف نظر کند. و درصدد محافظت از همسر مراجع باشد.
- طبق تبصره: درمانگر منافع مراجع را در نظر می گیرد که کمترین آسیب رو بینه و مراجع رو در جریان افشای امر می ذاره.
85. اگر مراجعی قصد ارتکاب جرم یا یزه داشته باشد، (مثلا بخواهد دزدی کند یا کسی را به قتل برساند) چه کار باید بکنیم؟
- ❖ به همان پاسخ سؤال 85 مراجعه شود.
86. اگر بین دو یا چند اصل اخلاقی گیر بکنیم، چه کار باید بکنیم؟
- ❖ طبق اصل حل و فصل مسائل و تعارض های اخلاقی / بند 1_10 از نظام نامه: وقتی تعارضی بین دو یا چند اصل اخلاقی به وجود میاد، باید ضمن بررسی و ارزیابی دقیق موقعیت و راه حل های ممکن، تمام تلاش رو واسه حل اون تعارض به کار گرفت، اگر تعارض حل نشه، با یادآوری تعهد به رعایت ضوابط اخلاق حرفه ای، راه حلی رو انتخاب می کنن که بیشترین پیامد مثبت و کمترین پیامد منفی رو واسه فرد یا افرادی که ازش تاثیر می پذیرن، داشته باشه.
87. هدف نظام نامه اخلاقی روان شناسان چیست؟
- ❖ به صفحه اول نظام نامه مراجعه شود. هدفش تعیین استانداردها و ضوابط اخلاقی واسه فعالیتی حرفه ای روان شناسا و مشاورا، تصریح حقوق مراجعا یا استفاده کننده ها از خدمات روان شناسی، و متخصصا و مشاوراست.
88. نظام نامه اخلاقی روان شناسی چند بخش دارد؟
- ❖ به صفحه اول نظام نامه مراجعه شود. این نظام نامه شامل دو بخشه: یک) اصول عمومی اخلاق حرفه ای. دو) استانداردها و ضوابط اخلاق حرفه ای.
89. اصل احترام مربوط به کدام بخش نظام نامه اخلاقی می شود؟
- ❖ اصل اول از اصول عمومی اخلاق حرفه ای سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران؛ "اصل احترام به شأن و آزادی انسان و تکریم شخصیت مراجعان"، هست.
90. اگر قرار باشد روان شناسی، پژوهشی انجام دهد، که مباحث اخلاقی در آن درگیر است؛ مثل: جراحی... چه باید بکند؟

❖ طبق بخش پژوهش و انتشار/ بندهای 2_8 و 3_8 از نظام نامه: باید اطمینان کنن که پژوهش طبق اصول اخلاق حرفه ای باشه و در صورت داشتن تردید، باید قبل از اجرای پژوهش، کمیته اخلاق حرفه ای دانشگاه یا سازمان محل خدمتش، به تصویب برسونه. اگه نبود، از کمیته ی اخلاق حرفه ای دانشگاه های دیگه یا سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، استعلام کنن.

91. به روز بودن دانش یک روان شناسی مربوط به چه اصلی است؟

❖ طبق بخش صلاحیت/ بند 1_5 از نظام نامه: واسه توسعه، روزآمد کردن صلاحیت و توانایی های حرفه ای تلاش باید کنن.

92. آیا یک روان شناس می تواند به دانشجویان یا کارورزهای خود، مشاوره بدهد؟

❖ مطابق بخش آموزش، کارورزی، نظارت/ بند 7_7 نظام نامه: نباید بهشون خدمات درمانی و مشاوره ای، ارائه بده. در صورت لزوم به متخصصای واجد شرایط، ارجاعشون بده.

93. در مورد مسائل مالی درمان، وظیفه ی یک روان شناس چیست؟

❖ کلاً قبل از شروع درمان باید شفاف و واضح در مورد مسائل مالی و هزینه مشاور باید آگاهی داده شود. ولی حق گرفتن مبلغی اضافه بر تعرفه وجود نداره. طبق بخش مداخله های روان شناختی/ بند 6_9 از نظام نامه: حق الزحمه ی خودش رو کامل طبق تعرفه دریافت می کنه، و از دریافت وجه اضافه بر اون باید اجتناب کنه.

در فصل چهارم/ کتاب اخلاق خانم حسینیان گفته شده که: روان شناس باید از شروع هر رابطه غیر حرفه ای مانند کاری یا مالی خودداری کند. اگر چنین رابطه ای برقرار شود؛ به عینیت روان شناس آسیب می رسد. یا در ایفای نقش او اختلال ایجاد می کند.

در کتاب مشاوره آسیب زا گفته شده که: مددکاری به جای مشاوره از مصادیق مشاوره آسیب زاست.

94. اگر مراجع وضعیت حاد روانی؛ مثل: سایکوز یا مسائلی داشته باشد؛ مثل: سن کم، که نتواند رضایت آگاهانه در درمان داشته باشد، روان شناس باید چه کار کند؟

❖ مطابق بخش روابط حرفه ای/ بند 2_9 نظام نامه: در مواردی که روان شناس و مشاوره به خاطر وضعیت حاد روانی، یا صغر سن مراجع، نتونه رضایت آگاهانه ی اون مراجع مورد نظر رو جلب کنه، باید رضایت قیم قانونی یا ولی اونو با حفظ شأن و منزلت مراجع، بگیره.

95. چه زمانی یک روان شناس می تواند، علت پژوهش و هدف پژوهش را از آزمودنی های خود پنهان کند؟

❖ طبق بخش پژوهش و انتشار/ بند 8_6 از نظام نامه: اولاً منافع پژوهش بیشتر از ضرر احتمالی باشه. دوم اینکه با روش های دیگه نشه اون پژوهش رو انجام داد.

96. اگر مراجعی بیماری مسری؛ مثل: HIV داشته باشد، وظیفه روان شناس چیست؟

- ❖ طبق بخش رازداری/ بند 4_5_3 از نظام نامه: جزء موارد نقض اصل رازداری و افشاء هست. و باید با کمترین آسیب و آگاهی مراجع این رو افشاء کنه و کارهای لازم رو انجام بده تا کسی به خطر نیافته.
97. آیا یک روان شناس در حوزه زوج و خانواده می تواند به عنوان شاهد، در دادگاه حضور داشته باشد؟
- ❖ طبق بخش مداخله های روان شناختی/ بند 6_8 از نظام نامه: به عنوان شاهد یکی ازشون بر علیه اون یکی، نباید شهادت بده.
98. اگر مراجع از ما نتایج آزمون خودش را بخواهد یا ارگانی، سازمانی، نتایج آزمون یک مراجع را از ما بخواهد، باید چه کار کنیم؟
- ❖ طبق موارد نقض رازداری/ بند 3_5 و زیر مجموعه 4_5_4 از نظام نامه: در صورتی که دستور مراجع قضایی باشه و با آگاهی مراجع و کمترین آسیب به ایشون باشه.
- همچنین طبق بخش سنجش، ارزیابی و تفسیر آزمون های روان شناختی/ بند 5_5 از نظام نامه: با درخواست کتبی مراجع یا قیم قانونی ایشون یا دادگاه با رعایت منافع و مصلحت مراجع می ده مگر بررسی بشه که باعث آسیب به مراجع یا سوءاستفاده از نتایج آزمون بشه.
99. یک روان شناس در اتاق درمان پرونده های مراجعین را تا چه مدتی باید نگهداری کند؟
- ❖ خب طبق بخش مداخله های روان شناختی / بند 6_4 از نظام نامه: باید خیلی ایمن بایگانی کرد حداقل تا 5 سال بعد از خاتمه ی مداخله.
100. اگر یک کودک 12 ساله، به شما مراجعه کرد، بعد از درمانش تا چند سال شما باید پرونده اش را نگاه دارید و بایگانی کنید؟
- ❖ خب طبق بخش مداخله های روان شناختی / بند 6_4 از نظام نامه: برای کودک یا نوجوان باید تا 11 زمانی که به سن قانونی برسن ازش نگهداری کرد.
101. آیا یک روان شناس، می تواند با مراجع خودش ازدواج کند؟
- ❖ طبق بخش مداخله های روان شناختی/ بند از نظام نامه: نباید باهاش ازدواج کنه. ولی حالا باید حداقلش دو سال از اتمام یا توقف مداخله ی درمانی گذشته باشه.
102. مراجع یک روان شناس، از او خواسته است که نتیجه ی آزمون را به او بدهد، در این موقعیت روان شناس، چه کار باید بکند؟
- ❖ به پاسخ سؤال 99 مراجعه شود.
103. در مشاوره ی زوج، اگر خانم مبتلا به بیماری مقاربتی باشد و همسرش در جریان نباشد، وظیفه روان شناس چیست؟
- ❖ به پاسخ سؤال 97 مراجعه شود.

 راهنمای حرفه ای

104. اگر مراجع در اتاق درمان پرخاشگری کند، وظیفه ی روان شناس چیست؟

❖ آرامش خودمونو حفظ می کنیم و دنبال علت پرخاشگری می گردیم. در این موقعیت بهتره که با "زبان بدن" و "صدای ملایم" باهاش هماهنگ شد و "همدلی" کرد. یا کلمات همدلانه ی کوتاه.

بعد اینکه ممکنه که با فریاد گریه کنه. و نیاز به بروز هیجان داشت بهش آموزش بدیم که این هیجانات دائمی نیس و گذرا هستن.

و بعد قبل از اینکه جلسه رو ترک کنه بهش احساس امنیت بدیم. با تکنیک تنفس و توجه آگاهانه به مثل بو و صدا و مزه با حواس 5 گانه. مراجع کم خطر: در صورت بروز پرخاشگری و یا فحش دادن مراجع اول حالت بدنی منفعل و غیر تهاجمی گرفت. خونسرد بود و با نفس عمیق و پذیرفتن نگرانی هاش با گوش دادن فعال این باور رو بهش بدیم که درک می شه. و کلیشه ای این کار رو نکنیم. پرسش های باز Open_ended مطرح کنیم. که جوابای طولانی تری دارن و پاسخ طولانی میدن. مراجع. حتی اگر مارو سرزنش کرد حتی شده عذرخواهی کنیم که چنین حسی بهش دادیم و همدلی کرد. اگه گف مشاور جذابی نیسی. عصبانی نشو. گوش کن یا حتی پرس چرا اینطور فکر می کنی؟ این نه تنها تنش رو کم می کنه بلکه به درمان هم کمک می کنه. در صورت حرفه ای نبودن این میدان جنگ خواهد بود و نه درمان. تا جایی که مراجع اطمینان حاصل کنه که متوجه نگرانی هاش شدیم.

و در آخر علاوه بر شفقت به مراجع ابراز کنیم که؛ تهدید یا فحش یا پول ندادن برای کلینیک و اتاق درمان شما قابل قبول نیس.

این نوع رفتار از مراجعینی سر می زنه که با افراد دیگر هم پرخاشگر هستن و فحش و ناسزا می گن یا به زور والدین و همسر به درمان اومدن، تضادورز هس یا چیزی برای پنهان داره یا کلاستر بی هست یا سایکوتیک بالا. اگر به خاطر به اجبار اومدنه؛ باید مراجع خودش بخواد. در غیر این صورت مختار هست که درمان رو ادامه نده. ولی اگر پرخاشگری در حد تهدید جانی بود پروتکل جداگانه داره خب APA می گه؛ خودمون داریم، این خطرها رو در نظر می گیریم. ولی خب جامعه اینو هنوز درک نکرده. خوبه که در صورت شک، آزمون MMPI_2 یا Meloy

گرفته بشه. دکمه اضطراری نصب بشه. و ال سی دی و دوربین مدار بسته باشه. که در ال سی دی قابل رویت باشه. در حین خطر باید محل رو ترک کرد. دکمه اضطراری رو زد. باید همکار مورد اعتماد داشت و در این مواقع زود مطلعش کرد. شب ها نباید کار کرد. تنها حتی المقدور با مراجع تنها در کلینیک نبود. دفاع شخصی بلد بود. اولش هم میشه بهانه های مختلف آورد مثلاً که من یه کاری دارم رسیدگی کنم و برگردم. خب اینجا هم یک سری راهکار واسه موقع خطر و کاهش اون داده. و خیلی خوب درجه ی موقعیت خطرناک رو آنالیز کرده.

<https://www.apaservices.org/practice/update/2010/01-27/patient-violence.pdf>

 در مورد راهکار برای لحظه موقعیت پر خطر می گه: استفاده از کلمات آرام و فرونشاننده. و اینکه یادش بیاریم تکنیک هایی که واسه رد کردن این موقعیت ازش استفاده می کرد. اگه بازم خارج از کنترل بود، گزینه های روی میز ایناست  "دکمه وحشت" یا "دکمه اضطراری" هم بهش می گن. و "خارج شدن از اتاق واسه کمک" و استفاده از "کدهای اضطراری" (که در سایت بیمارستان ها موجوده).

https://oldvct.iums.ac.ir/files/hosplo/files/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%DA%A9%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.pdf

این مقاله هم گفته؛ همکارا همو باید ساپورت کنن در این قضیه ها و اگه همکارتون مراجع پرخاشگر داشت؛ حواستون بهش باشه و حمایتش کنید. و اگه پرخاشگری لول پایین هم داشتین حتما یادداشت برداری کنید. و معمولا خودتون برای همچین تجربه هایی حتی لول پایینش، ترابی برید. و راجب تجربیات صحبت کنید. اینجا هم به آموزش این شرایط تاکید کرده.

<https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fpro0000035>

ولی خب... وقتی منصفانه ببینیم؛ مراجعین هم، خیلی مورد آزار و سوءاستفاده قرار می گیرن. لازمه اون ها هم آگاهی پیدا کنن، از حقوقشون. این هم جای کار داره.

105. اگر مراجع به جلسات مشاوره، دیر بیاید، وظیفه روان شناس چیست؟

❖ دو بحث مطرحه: اول اینکه در ص 168 کتاب خانم حسینیان، در قرار مشاوره ای میاد که قبلش باید اطلاع بده. و بعدش در مورد علت، سؤال بشه از مراجع. و مطلب دیگه اینکه: هیجانات خودمون رو بخاطرش کنترل کنیم. اگه خیلی دیر کنه خب راجبش فک می کنیم که مربوط به اتفاقات زندگیشه؟ سؤال می کنیم که علتش چیه؟ و تغییراتی در برنامه درمان ایجاد می کنیم.

106. اگر مراجعی نیاز به دارو، داشت؛ وظیفه روان شناس چیست؟

❖ به روان پزشک ارجاع دهد.

107. اگر مراجعی با مشکل نگرانی و ترس به روان شناس، مراجعه کند، تشخیص روان شناس در چه حوزه ای باید باشد؟

❖ ابتدا باید علائم اختلالات اضطرابی و فویهاها چک شود.

108. اگر مراجع، مشکلات زوج، داشته باشد؛ و این موضوع را به روان شناس کودک و نوجوان مطرح کند؛ وظیفه روان شناس چیست؟

❖ باید به متخصص مربوطه، ارجاع دهد.

 (خلاقیات حرفه ای)

109. اگر مراجع خواست با مدیرش در مورد مشکلش حرف بزنید و مشکل مراجع و مدیر را حل کنید، وظیفه روان شناس چیست؟

❖ در مورد ناهماهنگی انتظارات مراجع از مشاور در ص 24 اخلاق گفته که باید توافق کرد که امکان پذیر نیست. و طبق بند 2_3 اخلاق حرفه ای، این یک رابطه غیر حرفه ایه و طبق بند 6_5 مداخله روان شناختی، با نقش حرفه ایش در تعارضه. پس سعی می شه که به خود فرد کمک شه؛ تا شخصا مشکلشو برطرف کنه.

110. اگر در مشاوره ی پیش از ازدواج، مراجع پرسید که این فرد، با این فرد ازدواج کنم یا نه، پاسخ شما چیست؟

❖ بند تصمیم گیری به جای مراجع: "درمانگر حرفه ای برای شما تصمیم نمی گیرد. اگر درمانگر درباره ازدواج، بچه دار شدن، مهاجرت یا هر تصمیم بزرگ یا کوچک دیگر، به صورت مستقیم نظر یا دستوری ابراز کرد، احتمالاً در مسیر مخالف درمان و استقلال در حرکت هستید". لذا با بررسی شرایط و پرسش های کاوشگر انقدر پیش میریم که مراجع خودش پاسخ را بیابد.

111. اگر مراجع مشکلات مختلفی را مطرح کند و تعداد مشکلات زیاد بود، باید چه کار کنید؟

❖ باید اولویت بندی و رسیدگی کرد.

112. چطور در اتاق درمان می شود، مشارکت یک مراجع را گرفت؟

❖ یه ارتباط درمانی خوب که بر اساس اعتماد بنا شده. و با برقراری اتحاد درمانی، همدلی

113. اگر مراجعی از شما، نامه خواست؛ تا بتواند مرخصی بگیرد، باید چه کار کرد؟

❖ در پاسخ سؤال 110 مطرح شده.

114. اگر زوجی صحبتی کرد، در اتاق مشاوره، و از ما خواست به همسرش این موضوع را نگوئیم، وظیفه ی ما چیست؟

❖ طبق موارد نقض اصل رازداری نظام نامه نباشد، یعنی خطر جانی برای خود ایشون و دیگران نباشد. یا بحث بیماری مسری یا دستور قضایی در میان نباشد؛ همچنان رازدار خواهیم بود.

115. اگر مراجعی در اتاق مشاوره بگوید: "من نمی دانم از کجا شروع کنم؟"، روان شناس باید چه کار کند؟

❖ مشاور از ایشان پرسش های باز پاسخ، بپرسد که "علت مراجعه که او و انگیزه اش برای درمان" را جویا شود تا عامل ناراحتی مشخص گردد.

116. اگر مراجع موافق دارو خوردن نبود، وظیفه روان شناس چیست؟

❖ به پاسخ سؤال 110 مراجعه شود.

117. اگر مراجع آمد و گفت: "من نمی خوام کسی بداند من اینجا آمدم و به خانواده ام نگوئید"، باید چه کار کرد؟

❖ به پاسخ سؤال 115 مراجعه شود.

● (آشنایی با مسائل بومی، فرهنگی و اجتماعی)

118. نقش هلال احمر در حوزه سلامت روان، چیست؟

❖ رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر از تاسیس کلینیک، خدمات گروه سحر خبر دادن. همچنین خدمات توانبخشی و ارائه خدمات اجتماعی واسه پناه جوها و معلولین و واسه تفاهم و صمیمیت بین مردم، ارائه دارو، وسایل، تجهیزات درمانی و آموزشی با موافقت وزارت بهداشت هم دارن.

119. رسیدگی به تخلفات حرفه ای، پرستارانی که با بیماران حوزه ی روان، در ارتباط هستند؛ با چه ارگانی است؟
❖ سازمان نظام پرستاری.

120. نقش و وظیفه ی اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی چیست؟

❖ اقدامات اورژانس اجتماعی: پذیرش، خدمات تخصصی، ترخیص و پیگیری پس از ترخیص است.

121. خط بحران های اجتماعی چه خطی است؟

❖ پاسخ هر دو پرسش 117-118؛ تو کتاب مداخله در بحران می تونید ببینید که: خدمات مداخله در بحران به اورژانس اجتماعی مربوط می شه. مرکز مداخله در بحران به عنوان مرکز محور در برنامه اورژانس اجتماعی که دو تا بخش تخصصی و نگهداری موقت رو داره. بخشای اورژانس اجتماعی میشه: مرکز مداخله در بحران، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن 123، خدمات سیار اورژانس اجتماعی.

122. مشاوره تلفنی 1480 مربوط به کدام ارگان است؟

❖ مشاوره تخصصی تلفنی رایگان بهزیستی در حوزه های مختلف از جمله مشاوره های روان شناختی و حقوقی.

123. نقش کمیته امداد در حوزه ی سلامت، چیست؟

❖ حمایت مالی از قشر کم درآمد. خدمات مددجوها و مشاوره برای آنان.

124. اگر مراجع شما معلولیت جسمانی داشته باشد، او را برای گرفتن خدمات به کدام سازمان ارجاع می دهید؟

❖ اول کمیسیون پزشکی شدت و نوع معلولیت رو می گه. بعد سازمان بهزیستی به انواع معلولیتا رسیدگی می کنه.

● (سایر سؤالات - مهارتی و عملی)

125. اگر مراجع به شما پیشنهاد رابطه ی جنسی بدهد، چکار می کنید؟

❖ خب کلاً که طبق بند 6_6 مداخله های روان شناختی نظام نامه: باید از درگیر شدن در هر گونه رابطه ی جنسی با مراجع باید اجتناب کنه. حالا برخورد درست وقتی مراجع اینو می گه چی باید باشه؛ قسمت وابستگی خلاصه گلدارد ص 17 رو بخونید و بند 6-3 هم نگاه کنید. می گه که: مراجع به چند دلیل به مشاور وابسته می شه: اول اینکه رابطه مشاوره ای در ماهیت خودش صمیمیت، گرمی و پذیرش دارد و این خود به نوعی دوستی دامن می زند.

دوم اینکه مراجعان خصوصی ترین رازهایشان را به مشاوران می گویند و همین طرح موضوعات محرمانه باعث نوعی نزدیکی، اعتماد و حتی انتظار برای رابطه بلند مدت ایجاد می کند. سوم اینکه بسیاری از مراجعان، انسان های تنها و حتی رانده شده ای هستند که جریان مشاوره نوعی پناهگاه امن برایشان محسوب می شود و این کاملاً بدیهی است که در حالت افسردگی، اضطراب یا تنهایی بیشتر به دیگران وابسته شویم. و چهارم اینکه مشاور دارای موقعیت اجتماعی نسبتاً بالایی در جوامع برخوردار است. دارا بودن تحصیلات بالا، دیدگاه مثبت نسبت به این حرفه و نوع ارتباط همگی در وابسته شدن مراجع موثر است. از سوی دیگر وابستگی در مشاوره می تواند متقابل باشد. مشاوران انسان های ماشینی بی احساس نیستند بلکه با احساس و نیازهایشان زندگی می کنند. بنابراین مشاوران باید آگاه باشند که صرفاً برای ارضای نیازهای شخصی خود، مراجع را تشویق به ادامه جلسات نکنند، هنگام بروز وابستگی، مساله را بروز دهند و اعلام کنند که نسبت به آنچه در جریان است آگاهند و هرگز درگیر رابطه خارج از حوزه جلسات مشاوره نشوند. حالا اینم بگیم که کلاً انتقال که بهش نوروز انتقال میگن. یعنی انتقال احساسات و عواطف مثبت و منفی مراجع در خصوص افراد مهم زندگیش به مشاور. در چنین وضعیتی مراجع فراتر از بیان مشکل و طلب کمک تخصصی تمامی احساسات، حالات و جنبه های دردناک عاطفی خودشو به مشاور منتقل و به نوعی مشاور رو با نوروز های خودش درگیر می کنه. حالا اگه درمانگر ناآگاه باشه یا آماده نباشه، خب تصور می کنه که اونو یه انسان ویژه و برتر برگزیده دیدن با حسی مثل عشق و... یا با اون خصومت شخصی دارن.

126. اگر مراجع از شما خواست، علاوه بر اینکه به او مشاوره می دهید؛ به خواهرش هم مشاوره بدهید، شما چه کار می کنید؟ ❖ موافقت یا عدم موافقت خود مراجع به عنوان درمانجوی اول مهمه. اگر از اینکه خواهرش، درمانگر مشترک باهاش داشته باشه، یا درمانگرش با یکی از آشناها رابطه برقرار کنه، احساس خوبی نداره به درمانگره، عنوان کنه. در غیر این صورت در اخلاق حرفه ای ممناعتی براش نیس. خلاصه باید توافق کرد. نیاز خود مراجع در اولویته.

[https://www.mhaw.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-](https://www.mhaw.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87%d8%a7%db%8c/)

بخش نمونه سؤالات سایت

[%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87%d8%a7%db%8c/](https://www.mhaw.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87%d8%a7%db%8c/)

127. اگر درمان کنید و پیشرفت کم باشد چه کار می کنید؟

❖ خب اصل سودمندی از اخلاق حرفه ای در مشاوره، میگه که؛ ما همیشه باید خیر و صلاح مراجع رو در نظر بگیریم. لذا اگر جواب نداد؛ پس به قول گلدارد، بررسی راه حل ها و کشف گزینه ها.

128. اگر مراجع از رویکرد شما بپرسد، چه می کنید؟

❖ حق آیشونه که سؤال بپرسن. و وظیفه ی ماست خیلی شفاف، صادقانه، غیر تخصصی آگاهی بدیم. که با این رویکرد، فلان طور پیش می ره براتون.

129. اگر مراجع از رویکرد شما نگران باشد و بخواهد رویکرد و نوع درمان را تغییر دهید، چه می کنید؟

❖ باهاش گفتگو صادقانه ای می کنیم، به نگرانی های ایشون توجه می کنیم. بدون وادار به پذیرش کردن ایشون به توافق می رسم. ص 24 اخلاق. سؤال 57 آزمون بوده.

130. اگر مراجع بخواهد به درمان پایان دهد، چه می کنید؟

❖ خب در مورد ناهماهنگی انتظارات مراجع ص 24 اخلاق گفته که باید توافق کرد. ولی وادار به پذیرش نکرد. از طرف دیگه طبق بند خودمختاری از اصول اخلاق حرفه ای در مشاوره، مراجع در ادامه و پایان روند درمان کاملاً آزاد. هیچ فرد حقیقی و حقوقی هم نباید مجبورش کنه. همسر یا والدین و غیره هم مجبورش کنن و صرف نظر از شرایطی که مراجع در اون قرار داره، باز هم اجبار کردنش درست نیست. چون باید فرصت فکر کردن و تصمیم گیری خلق کنه تا کمک بخواد.

131. اگر مراجع به اصرار بخواهد نامه ای بدهید که درمان شده و از دعوا با همسر خود پشیمان هست؛ چکار می کنید؟

❖ اصلاً این مداخله زیادیه دیگه. طبق نظام نامه بند 1_4 از بخش مسئولیت امکان پذیر نیست. چون درمانگر مسئولیت داره بابت رفاه و بهزیستی نه تنها مراجع، بلکه تمام کسانی که تحت تاثیر اقدامات در چارچوب خدمات درمانی و مشاوره ای اونها هست. و باید منافع اون ها هم در نظر بگیره.

در بند 2_6 بخش روابط حرفه ای هم میگه قرارمون نمی شه از موقعیت درمانگری خودش سوءاستفاده کنه و این حرکتارو بزنه.

132. اگر مراجع به اصرار شماره تلفن همراهتان را بخواهد؟

❖ ببینید APA یه سری مرزها (Boundaries گفته: 1) مرزهای فیزیکی شامل؛ بوسه و در آغوش کشیدن... (داخل پرانتز، طبق اخلاق حرفه ای کشور ما، در فرهنگ ایران، برای مشاور جنس مخالف، حتی اگر مراجع خواست دست بده؛ باز مشاور اجازه نداره. مشاور همجنس هم، اگر خود مراجع راضی باشه و تمایل داشته باشه موردی نیست. حالا اما اگه مراجع همجنس، در حال گریه شدید هم بود، مشاور دستی به سرش بکشه، بلا مانعه. به شرطی که در همین حد باشه. در غیر این صورت اصلاً اجازه نیست هیچ تماسی برقرار شه. حتی مراجع هم جنس، بخواد در آغوش بکشه، مشاور اجازه نداره این نوع تماس رو برقرار کنه. گاهی مشاور سوءاستفاده گر _ خب در هر حرفه ای، انسان خاطی هست دیگه _ بیان می کنن که این ارتباط فیزیکی در درمان تاثیر مثبت داره. دوستان لازمه بگیم هیچ جای علم روان شناسی چنین چیزی اثبات نشده. و شما چه مراجع و چه مشاور به هیچ عنوان نباید اجازه ش رو بدین. اگر بود مراجع می تونه شکایت کنه از مشاور). (2) مرزهای فکری؛ شامل؛ عقاید شخصی ما میشه. که نباید واسه اتاق درمان بشه. (3) مرزهای عاطفی؛ شامل اطلاعات شخصی درمانگر یا حتی کوچیک شمردن احساسات و عواطف مراجع میشه. (4) مرزهای جنسی؛ که واضحه؛ نوع گوش کردن، لمس کردن و نشون دادن تمایل مختص خودش رو در برمی گیره. (5) مرزهای مادی؛ کادو گرفتن و دادن اضافه بر سازمان و امثالهم... (6) مرزهای زمانی؛ یعنی درمانگر زمان

زندگی شخصیش، روابط کاریش و درمانیش، زمان سرگرمی و تفریحش... همه و همه باید جای خودش باشه و هیچ کدوم همدیگه رو نقض نکنه.

حالا با توجه به این مرزها که مشخص و تعریف شده هست؛ باید یک سری Red Flags برای اتاق درمان خودتون تعریف کنید. یعنی چی؟ شماره دادن به مراجع رو، رد فلگ می بینیدش؛ نمی خواین این کارو کنید. خب به مراجعتون میگید این شماره منشی بنده ست. در صورتی که مشکلی پیش آمد از طریق منشی، من رو باخبر کنید. ایشون پیغام اضطراری شما رو می رسونن. ولی کلاً اگر یه چیزی براتون رد فلگ هست. تغییر سیاست کار حرفه ای و محترمانه ای نیست. مطابق اخلاق حرفه ای در مشاوره،

مشاور اجازه نداره فشار بیاره واسه شماره همراه مراجع. متقابلاً خود مشاور هم حق داره که، شماره اشو به مراجع نده. بازم گاهی ممکنه برای فرستادن یه فایلی مربوط به جلسه درمان یا واسه شرایط حساسی که مراجعان خاص دارن. مشاور شماره شو میده؛ بعدش حالا دیگه وظیفه ی جواب تماس ها و TEXT های بلند رو ، نداره دوستان. اگه مشاور مدام جواب تماس داد یا تسکت طولانی پاسخ داد،، خب غیر حرفه ایه (چون ضروری بود، فقط باید کوتاه و چند کلمه ای پاسخ داد).

133. ضوابط ارجاع مراجعین به دیگر همکاران به چه صورت می باشد؛ در چه صورتی این ارجاع جزء جرائم و در چه صورتی جزء درمان می باشد؟

❖ شش گاهی واسه "تداخل نیاز" اتفاق می افته یا زمانی که موضوع مورد بحث در تخصص درمانگر نباشه. حالا مصادیق ارجاع رو بگیم: ترجیح مراجع باشه حالا یا واسه سن مشاور، جنسیت، تحصیلات، درجه مذهبی بودن، عدم هماهنگی در زمان، ماهیت متفاوت مشکل، وابستگی شدید مشاور و مراجع، عدم توافق تصمیم گیری، تفاوت ارزشی و شرایط ویژه ای مته دور از جون بیماری و مهاجرت و سربازی و... . مصادیق ارجاع عبارتند از: ترجیح مراجع به تغییر مشاور به لحاظ سن، جنسیت، میزان تحصیلات و درجه مذهبی بودن، عدم هماهنگی در زمان (که مراجع باید با زمان حضور مشاور هماهنگ شود)، ماهیت متفاوت مشکل، بروز وابستگی شدید بین مشاور و مراجع، عدم توافق بر سر برخی تصمیم ها و یا تفاوت ارزشی و بروز شرایط ویژه (مانند بیماری یا مهاجرت). نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که ارجاع از مصادیق افشاء نیست. به منظور پیشگیری از اتلاف وقت مراجع و جلوگیری از هزینه های اضافی وی بایستی با درباره انتقال اطلاعات به متخصص بعدی گفتگو کرد. یعنی تنها بدین خاطر که مراجع راضی به ادامه جریان مشاوره نزد متخصص دیگر شد، نمی توان اطلاعات محرمانه اش را بدون هماهنگی در میان گذاشت. از این جهت مشاور باید هنگام معرفی مراجع حتماً از وی درباره مطالبی که می خواهد منتقل کند، بپرسد و رضایت آگاهانه او را جلب کند. از این جهت بطور دقیق باید بداند که کدام بخش از اطلاعات مراجع را می تواند بگوید و کدام بخش را حق ندارد بازگو کند. نکته مهم دیگری که در این ارتباط وجود دارد بحث صلاحیت متخصص دوم است. روان شناسان و مشاوران بایستی از صلاحیت علمی و اخلاقی متخصصی که مراجع را به وی ارجاع می دهند کاملاً مطمئن

باشند زیرا شتاب زدگی در این موضوع ممکن است نتایج جبران ناپذیری داشته باشد. مسئولیت پذیری به لحاظ اخلاقی مسئولیت جریان مشاوره با فرد روان شناس یا مشاور است. مثلاً چون مراجع راضی به ادامه جریان مشاوره پیش شخص دیگه نشه، نباید بدون اجازه افشاء راز کرد و این ها.

حقّ الزحمه بابت ارجاع گرفتن از متخصصّ دیگه؛ تو ACA هم اشتباهه. و تا مشاور فهمید باید ارجاع بده، روند درمان رو نباید ادامه هم بده. یعنی قطع فوری درمان. NAC هم میگه باید از متخصصّی که بهش ارجاع می دیم؛ مطمئن بود.

اگر حقّ رضایت آگاهانه و افشاء راز نادیده گرفته بشه مراجع می تونه مدعی بشه. در صورت رعایت موارد بالا که گفته شد جزء درمانه. قانون حمایت از حقوق مراجعان و حمایت از حقوق صنفی روان شناسان و مشاوران در تبصره یک ماده 19 یکی از تخلف های منجر به محکومیت اعضای سازمان؛ تخلف از شئون حرفه ای و صنفی؛ به معنای عدول از اصول نظام نامه.

134. مواردی که باعث می شود ما رازداری را شکسته و رازداری را حفظ نکنیم شامل چه مواردی می باشد؟

❖ در نظام نامه چند مورد رو از مصادیق افشاء قید کرده که در همه ی این موارد مراجع باید آگاه باشه نسبت به افشاء و اینکه به شرط به خطر نیافتادن منافع مراجع باشه. اول: بنا به درخواست و رضایت مراجع یا قیم قانونیش باشه. دوم: زمانی که پای یک بیماری مسری مثل HIV و... در میون باشه. سوم: زمانی که خطری جانی برای مراجع یا دیگران باشه. یعنی خود کشی یا دیگر کشی. چهارم: زمانی که حکم قانونی یا مراجع قانونی موجود باشه. پنجم: شکایت و دادخواهی مراجع بر علیه مشاور. ششم: دادخواهی مراجع بر علیه کسی که برای او مزاحمت ایجاد کرده است. هفتم: محدودیت های مقرراتی-کشوری. هشتم: هدف ثبت و دلایل حقوقی.

ولی در اخلاق حرفه ای مشاوره مواردی مثل، عضویت در باندهای مخرب، عدم توانایی از دفاع حقوق خود هنگام در معرض قرار گرفتن سوء استفاده های جنسی، مالی یا ... و الزام ثبت اطلاعات در پرونده، وجود شرایط کمک گرفتن از ناظر، شرکت در همایش ها و سمینارهای ملی یا بین المللی با شرط محرمانه بودن هویت مراجع، نامه دادگاه مبنی بر ارائه تشخیص حرفه ای باشه و در نهایت ایجاد شرایط دفاع از حقوق شخصی.

135. آیا یک مشاور می تواند به صورت یک شاهد در دادگاه حضور پیدا کند؟

❖ دستور دادگاه برای دریافت اطلاعات از مصادیق افشاء راز هست با آگاهی مراجع. در واقع گاهی به دلایل حقوقی دادگاه درخواست می دهد که اطلاعات مراجع خاص را در اختیار شان قرار بدهیم در اینجا مشاور موظف است اطلاعات خواسته شده را در اختیار دادگاه قرار دهد و به مراجع خود اطلاع دهد و آگاهی کند. ولی برای زوج درمانگر اگر باشه، درست نیس که؛ بر علیه یکی از زوجین بخاطر دیگری شهادت بده.

136. آیا یک مشاور می تواند اطلاعات پرونده خود را کاملاً به دادگاه ارائه نماید؟

❖ شکایت و دادخواهی مراجعان بر علیه مشاوران از مصادیق افشاء راز. در واقع گاهی مراجعی برای موضوعی خاص از مشاور خود شکایت می کند در اینجا اگر لازم باشد مشاور می تواند اطلاعات مراجع را در آن زمینه ای که از ایشان شکایت کرده در دادگاه فاش کند.

137. دقیقاً کدام فیلد از فیلدهای روان شناسی اجازه گرفتن تست و تفسیر تست را دارند شما این فیلدها را می شناسید؟

❖ روانسنجی و روان شناسی بالینی.

138. یک تست استاندارد چه شرایط و ضوابطی از دیدگاه نظام روان شناسی بایستی داشته باشد استانداردهای یک تست چیست؟

❖ باید معتبر و هنجاریابی شده باشد. اعتبار و پایایی داشته باشد. مستند و استاندارد باشد. خود درمانگر باید صلاحیت لازم رو برای استفاده از تست رو داشته، به روز و مسلط به علم روانسنجی.

139. آیا در آزمون هایی که نیاز به استفاده از سیستم کامپیوتری است دستیاران و منشی ها می توانند در این خصوص آزمون هایی از

مراجع گرفته و سپس تفسیر را خود مشاور انجام دهد؟

❖ فقط در صورتی که صلاحیت این کار را داشته باشند.

140. تا چندین سال بایستی پرونده های مراجعین بایگانی شود؟

❖ حداقل تا 5 سال پس از درمان. در کودکان هم، تا زمان رسیدن به سن قانونی.

141. قانون تخصصی پکیج های ارائه شده به مراجعین از طرف کلینیک ها، یا مشاوران از نظر سازمان نظام روان شناسی چیست؟

❖ به بخش مربوط به تبلیغات و خدمات عمومی، همچنین بخش آموزش در فایل نظام نامه مراجعه شود.

142. از دیدگاه سازمان نظام روان شناسی چند ساعت سوپرویزن برای یک مشاور در زمینه های مختلف لازم و ضروری به نظر می رسد؟

❖ شرط ساعت 150 ساعت کارگاه و 150 ساعت کارورزی که 300 ساعت می شود؛ از درگاه ملی حذف شد. الان در حدی باید

کسب دانش و تجربه داشت که بتوان سؤالات چالشی آزمون را پاسخ داد.

143. مسئولیت کسانی که دوره های کارآموزی را اجرا می کنند و مجریان دوره های کارآموزی و سوپرویزن از دیدگاه سازمان روان شناسی چیست؟

❖ در فایل نظام نامه درج شده که: * فقط باید برنامه های آموزشی، کارآموزی و کارورزی رو به عهده بگیرن که دانش و تجربه

لازمش اجراشو داشته باشند. * باید دانشجو ها، کارآموزا و کارورزا رو، از سر فصل، محتوی و فرایند برنامه ی آموزشی خودشون

آگاه کنن. * محتوی و برنامه ی آموزشی، کارآموزا و کارورزی که ارائه می شه؛ باید مرتبط، علمی، دقیق و به روز باشه. * باید

در برنامه های آموزشی، کارآموزی و کارورزیشن، اهداف، انتظارا، محتوی آموزشی و نحوه ی ارزشیابی برنامه رو مشخص

کنن. * باید نظارت کامل روی نحوه ی اجرای کارورزی هایی که مسئولیتشونو دارن، داشته باشن بعد هم بازخوردای لازم رو

به کارورزا هم بدن. *بعدم باید با ارزیابی مداوم، از قابلیت و محدودیتای شخصی و علمی کارآموزا و کارورزا آگاه شن و در صورتی هم که محدودیتا مانع تحقق اهداف کارآموزی و کارورزی باشه، بیان واسه رفعشون اقدام کنن. *به کارآموزا و کارورزاشون، نیان خدمات درمانی یا مشاوره ای هم ارائه بدن. اگر لازم داشتن به متخصص حسابی و واجد شرایط ارجاع بدن. *دانشجوها، کارآموزا و کارورزا رو به پیروی از اصول اخلاق حرفه ای توصیه کنن. *و اینکه مرزای اخلاقی، حرفه ای و اجتماعی رو با دانشجوها، کارآموزا و کارورزای خودشون، مشخص کنن و بعدم رعایت هم بکنن. از هر رابطه ای که به هر شکلی منجر به سوء استفاده شه، حتما اجتناب کنن. *در طول دوره آموزش و کارورزی، حرمت دانشجوها، کارآموزان رو، حفظ کنن و از ورود به حیطه های زندگی شخصی شون، خودداری کنن. *اصلاً هم نباید کارکنان، کارمنداشونو یا بستگان نزدیکشونو به عنوان کارآموز و کارورزان بپذیرن. *در برنامه های آموزشی زمینه ی مناسب واسه آشنایی و کسب تجربه دانشجوها، کارآموزا و کارورزا، در خصوص دیدگاه ها و فنون مختلف روان شناختی و مشاوره ای فراهم شه و اونا به توسعه ی تجربه های علمی و عملی خودشون ترغیب شن. *صرفاً در چارچوب صلاحیتا و تواناییای واقعی اون فرد و بر اساس شناخت شخصی از فرد، توصیه علمی واسه افراد نوشته شه.

144. از لحاظ قانونی در سازمان نظام روان شناسی در انتشار مقالات دانشجو به عنوان نویسنده چندم استاد به عنوان نویسنده چندم و مسئول مقاله بایستی چه کسی باشد؟

❖ مطابق بندهای مربوط به بخش پژوهش نظام نامه: *مسئولیت لحاظ علمی و اخلاقی پژوهش بر عهده ی مجری طرحه، در عین حال هم تمام افرادی که به نوعی درگیر انجام این پژوهش هم، به سهم خودشون، در قبال اعمال و وظایف پژوهشی مسئولن. *نباید مسئولیت و امتیاز کارایی که انجام ندادن، یا هیچ نقش و نظارتی تو اجراشون، نداشتن، بپذیرن. *مقاله هایی هم که از پایان نامه های دانشجویی، استخراج میشه؛ نام دانشجو، میشه مولف اول مقاله. مگر اینکه حالا دانشجو نقشی تو استخراج مقاله از پایان نامه ش، نداشته باشه.

145. چگونه یک نفر می تواند واجد صلاحیت شرکت در پژوهش های روان شناسی باشد؟

❖ طبق نظام نامه؛ باید داوطلبانه باشه و رضایت آگاهانه از اونها و عدم تمایل به همکاری افراد نباید اصلاً تبعات منفی براشون داشته باشه. منافع و خطرات احتمالی شرکت در پژوهش، قوانین رازداری در پژوهش و حق انصراف فرد، نوع فعالیتی که باید انجام شود؛ ضروریست کاملاً برای فرد توضیح داده شود.

146. در صورت چاپ کتاب اولویت مولفین به عنوان نویسندگان کتاب از دیدگاه سازمان نظام روان شناسی باید چگونه باشد؟

❖ به پاسخ سؤال 145 مراجعه شود.

147. کد اخلاق حرفه ای چیست و این کد را از کجا بایستی تهیه کرد؟

❖ کد اخلاق در پژوهش، شناسه ایست که توسط کمیته اخلاقی و پژوهشی دانشگاه صادر می شه. در صورتی که تو پروپوزال، اشکالی از نظر رعایت حقوق و سلامت آزمودنی ها وجود داشته باشه، اعضای کمیته، اعلام می کننش و از مجری طرح، می خوان که اشکالاتو برطرف کنه. در نهایت، چنانچه پروپوزال از نظر مقررات و کدهای اخلاقی، مورد تأیید کمیته باشه، پروپوزال، تو دبیرخونه کمیته اخلاق در پژوهش ثبت می شه و با نامه ای، یه کد ثبت به مجری طرح اعلام می شه.

این کد باید در "سامانه ملی اخلاق در پژوهش"، قابل دیدن باشه. حتماً باید کد ثبت فوق الذکر و لینک دسترسی به صفحه ای از سامانه فوق الذکر که، اطلاعات پروپوزال طرح مرتبط، در آن، قرار داره رو هم تو زیرمجموعه ی بخش Ethics یا Acknowledgements گزارش کار و یا مقاله گذاش.

انواع اصلی کدهای اخلاقی شامل: وظایف به مراجع ها_ وظایف نسبت به عموم_ وظایف به شرکت. مشاغل هم ملزم به ایجاد یک کد اخلاقی هستن.

148. کمیته ارزیابی اخلاق حرفه ای در کدام مکان ها مستقر هستند و چگونه می توان با این کمیته ها در ارتباط بود؟

❖ در معاونت پژوهشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.

از طریق کارشناس کمیته اخلاقی و پژوهشی می توان با آن ها در ارتباط بود.

149. کدام دسته از پژوهش ها نیاز به کد اخلاق حرفه ای دارند؟

❖ همه مطالعاتی که آزمودنی هاش، انسان یا حیوان هستن. پژوهش های که مداخلات آزمایشی و درمانی بر روی شرکت کنندگان انجام می شود.

150. اگر یک روان شناس دچار تعارضاتی با مراجعین خود شد چگونه و با چه مراحل بایستی این تعارض را حل کند؟

❖ اگر بین دو یا چند اصل اخلاقی، تعارضی پیش اومد؛ باید ضمن اینکه بررسی و ارزیابی دقیق موقعیت و راه حل های ممکن، رو صورت بده؛ باید تمام تلاش خودشو صرف حل تعارض مذکور کنه. اگر تعارض حل نشد، با یادآوری تعهدش به رعایت ضوابط اخلاق حرفه ای، بیاد یه راه حلی رو پیش بگیره که بیشترین پیامد مثبت رو برای فرد یا آدم هایی که ازون تاثیر می گیرن، داشته باشه و کمترین پیامد منفی براشون. جاهایی هم که بین ضوابط اخلاق حرفه ای و قانون تعارض وجود داشت باید منطقی برای حل تعارض طبق ضوابط حرفه ای عمل کنه. اگرم جوری باشه که این تعارض غیرقابل حل باشه هم، طبق قانون بره.

خب حالا اگه بین ضوابط اخلاق حرفه ای و مقررات اون سازمانی که در اونجا مشغول بکار هستن تعارض باشه چی؟ اونجا باید طبق ضوابط اخلاق حرفه ای پیش بره. اگر م می پرسید کجا گفته مراجعه کنید به صفحه 103 اخلاق حرفه ای از کتاب آقای عاطف و خانم دادور.

151. در رابطه با تبلیغات قوانین سازمان چیست به صورتی که یک روان شناس از لحاظ قانونی دچار جرائم سازمان نظام روان شناسی نشود؟

❖ *طبق بخش تبلیغات و خدمات عمومی در نظام نامه، هر گونه اظهار کذب و جعلی در خصوص آموزش، تجربه، شایستگی درجات تحصیلی، مدارک، وابستگی های سازمانی یا انجمنی، خدمات، پایه های علمی یا بالینی یا درجات موفقیت خدمات، کتب منتشر شده و کشفیات پژوهشی خود اجتناب می کنند. *باید وقتی از طریق کتاب، مجلات، روزنامه ها، اینترنت، رادیو و دیگر ابزارهای ارتباط جمعی برای عموم مردم پیشنهاد یا توصیه ارائه می کنند، توجه و دقت کافی برای تضمین این نکته که اظهارات ارائه شده واجد شرایط زیر باشد را مبذول می نمایند: اول اینکه، بر پایه ی دانش روزآمد روان شناختی و تجربه های حرفه ای آن ها باشد. دوم اینکه، در چارچوب صلاحیت ها و تخصص آنها باشد. سوم اینکه، با کدهای اخلاق حرفه ای روان شناسان و مشاوران منطبق باشد. چهارم اینکه، دلالت بر آن نداشته باشد که رابطه ی حرفه ای با مخاطبان برقرار شده است *در مواردی که رسانه های جمعی، انجمن ها، گروه ها و افراد؛ در خصوص مدارک، تخصص، توانایی ها؛ خدمات و اظهارات آن ها اطلاعات نادرستی را ارائه می دهند، در اسرع وقت و به نحو مقتضی برای تصحیح آن اقدام می نمایند. *هنگامی که متخصصین از فرد، افراد یا سازمانی برای تبلیغ خدمات تخصصی خود استفاده می کنند، از صحت مطالب ارائه شده اطمینان حاصل نموده، بر فرایند تبلیغات نظارت نموده و مسئولیت آن را بر عهده می گیرند *در ارائه ی آموزش های عمومی نسبت به کار آمدی، موثر بودن، روز آمدی و صحت این آموزش ها اطمینان می یابند. *در چهارچوب حوزه ی تخصصی و در حد توان خود در فعالیت های اجتماعی مرتبط با توسعه و بهبود رفاه اجتماعی و حفظ گسترش منافع عمومی (از جمله سیاست گذاری های اجتماعی، اصلاح قوانین و مقررات، و مانند آن)، مشارکت می نمایند. *بخشی از درمان خود را به ارائه ی خدمات تخصصی عام المنفعه به افراد و گروه های نیازمند اختصاص می دهند. *به صورت داوطلبانه نسبت به ارائه ی خدمات تخصصی روان شناختی و مشاوره ای در شرایط بحران و اضطرار (از جمله بلایای طبیعی و مانند آن) اقدام می نمایند.

152. اگر یک مشاور خلاقی را در رابطه با همکار خود دید به ترتیب چه مراحل را بایستی طی کند تا از این خلاف و این جرم جلوگیری نماید؟

❖ دو بند آخر نظام نامه میگه: ابتدا سعی کن که با تذکر به آن همکار از ادامه تخلف جلوگیری کن. در صورتی که موثر واقع نشد، به مسئولان بالاتر اطلاع بدن و اگر هم تکرار تخلف صورت گرف، موضوع رو به "کمیسیون رسیدگی به تخلفات حرفه ای سازمان نظام روان شناسی و مشاوره" اطلاع بدن. باید هم در جریان رسیدگی به پرونده های متخلفین همکاری های لازم رو با "کمیسیون رسیدگی به تخلفات حرفه ای نظام روان شناسی و مشاوره" داشته باشن.

153. اصل احترام و به شأن و آزادی انسان ها شامل چه مواردی از دیدگاه سازمان نظام روان شناسی می باشد؟

❖ اولی از اصول عمومی اخلاق حرفه ای سازمان نظام روان شناسی؛ "اصل احترام به شأن و آزادی انسان و تکریم شخصیت مراجعان"، هس. "شامل حق حریم شخصی، رازداری و اختیاره. یعنی باید به منزلت و ارزش همه ی انسان ها احترام بزارن. و حریم خصوصی، محرمانه بودن، و حق تعیین سرنوشت افراد رو رعایت کنن. آگاهن که تدابیر حفاظتی خاصی ممکنه برای حفاظت از حقوق و رفاه افراد یا جوامع مستقل لازم باشه. آگاه باشن و به تفاوت های فرهنگی، فردی و نقشی، احترام بذارن؛ از جمله با کسانی که براساس سن، جنسیت، هویت جنسی، نژاد، قومیت فرهنگ، ملیت، مذهب، گرایش جنسی، ناتوانی، زبان، و وضعیت اجتماعی_اقتصادی متفاوتن، و این عواملو؛ در کار با این گروه ها در نظر می گیرن. تا کارشونو از سوگیری بر این عوامل مبرا کنن و آگاهانه درش شرکت نکنن، یا از فعالیتهای سوگیرانه ی دیگه، بر اساس تعصبات چشم پوشی نکنن. ارجاع به صفحه 73 اخلاق حرفه ای عاطف و دادور.

154. اصل سوددهی از دیدگاه سازمان نظام روان شناسی چیست؟

❖ یعنی تمام فعالیت ها و خدمات مشاوره ای باید در جهت خیر و صلاح مراجع باشه و هرگز نباید نسبت به اونچه که در جهت رشد و شکوفایی مراجعه کوتاهی کرد. اصولا مشاورا نیاز دارن که به تمام رفتارهای خودشون نظارت داشته باشن تا از تاثیری که بر مراجعشون میذارن، آگاه باشن. از این جهت ارزش های مراجع، نسبت به موضوعات اساسی زندگی و تصمیمی که در نهایت می گیره؛ به ارزش ها و باورها و تصمیم های مشاور، ارجحیت داره. وظیفه ما چیه؟ اینجوری نیس که وادار به پذیرش پیشنهادات، توصیه ها یا تکالیف خودمون کنیم و گیر بدیم بهش. بلکه وظیفه ما معرفی مناسب ترین نقشه راهبردی. و اینکه ترغیب به انجام دادن و قرار گرفتن در مسیر جدیدش کنیم که براش تضمین کننده سلامتی و شکوفاییه. به علاوه متخصص حرفه ای وقتی می تونه از سودمندی خدماتش مطمئن شه که شرایط استاندارد ارائه خدمات مشاوره ای هم داشته باشه. حالا این شرایط در بقیه ی اصول اخلاق حرفه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته.

155. در چه مواردی یک مشاور حتی اگر صلاحیت حرفه ای نداشته باشد می تواند مداخله در درمان داشته باشد؟

❖ ارجاع.

156. منافع مراجعین از دیدگاه سازمان نظام روان شناسی شامل چه مواردی است؟

❖ *روان شناسا به حقوق افراد و گروهی که باهاشون کار می کنن، باید احترام گذاشته و تمام سعی خودشونم برای حفظ منافعشون، بکنن. *وقتی هم تضادی بین منافع مراجع و مؤسسه ای که روان شناس اونجا کار می کنه، پیش بیاد؛ روان شناس باید موقعیت و وفاداری و وظیفه شناسی خودشو، مشخص کنه. *مراجعینشونو از اهداف و ماهیت ارزیابی ها، درمان، روش های آموزشی و... کاملا آگاه کنن و آزادانه اعلام کنن که مراجعین، دانشجویان، یا شرکت کننده های پژوهش، کاملا در شرکت یا عدم شرکت در پژوهش، آزادی انتخاب دارن.

الف) روان شناسا، مستمر از نیازاشون و موقعیت و نفوذشون در ارتباط با افرادی مثل: مراجعین، دانشجویها، زیردستان... آگاهن. روان شناسا از سوء استفاده از اعتماد و وابستگی این ادم ها، به خودشون، اجتناب می کنن. روان شناس ا تمام سعی خودشونو می کنن؛ که از روابط دوگانه که می تونه، قضاوت حرفه ای شونو خدشه دار کنه، و خطر استفاده و استثمار رو افزایش بده، اجتناب کنن. نمونه های روابط دوگانه شامل موارد زیر می باشد؛ هرچند که محدود به آنها نمی شود: پژوهش یا درمان روی کارمند، دانشجویان، افراد تحت نظارت، دوستان نزدیک یا اقوام. روابط جنسی با مراجعین غیراخلاقیه.

ب) وقتی روان شناسی، به درخواست فرد سوم، به مراجعی خدمات ارائه می ده؛ روان شناسا وظیفه خودشون می دونن که ماهیت روابطشونو با همه ی افراد درگیر روشن کنن.

اخلاق حرفه ای عاطف و دادر، صفحه 82.

157. روان شناسان در خصوص مسائل مالی بایستی چه قوانینی را رعایت کنند که دچار جرائم سازمان نظام روان شناسی نشوند؟

❖ *باید حق الزحمه خدمات روان شناختی و مشاوره ای خودشونو طبق تعرفه های "سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران" دریافت کنن و وجه دیگری از مراجعان دریافت نکنن. (نظام نامه). *در ارتباط با مسائل مالی قبل از شروع درمان، اطلاعات لازم رو در اختیار مراجعین قرار بدن؛ و توافق آگاهانه شونو به دست بیارن. (نظام نامه). *در فصل چهارم/ کتاب اخلاق خانم حسینیان گفته شده که: روان شناس باید از شروع هر رابطه غیر حرفه ای مانند کاری یا مالی خودداری کند. اگر چنین رابطه ای برقرار شود؛ به عینیت روان شناس آسیب می رسد. یا در ایفای نقش او اختلال ایجاد می کند.

در کتاب مشاوره آسیب زا گفته شده که: مددکاری به جای مشاوره از مصادیق مشاوره آسیب زاست.

158. پس از چه زمانی یک مشاور می تواند رابطه کاری دیگری یا رابطه عاطفی و ازدواجی با مراجعه خود داشته باشد؟

❖ بند 6_7 از بخش مداخله روان شناختی در نظام نامه ذکر شده که: حداقل دو سال از اتمام یا توقف مداخله ی او نا باید گذشته باشه که امکان ازدواج درمانجو و درمانگر باشه.

159. از دیدگاه سازمان روان شناسی چه زمانی نیاز به اجرا و تفسیر تست برای مراجع وجود دارد؟

❖ بند 5_4 بخش سنجش، ارزیابی و تفسیر در نظام نامه میگه: باید به صورت هدفمند و متناسب با نیاز و صرفاً در چارچوب تشخیص، درمان، راهنمایی، مشاوره و درمان استفاده بشه.

160. آیا لازم است که در مورد شیوه مداخلات روان شناسی خود به مراجعین توضیحاتی ارائه دهیم؟ این جز قوانین سازمان نظام است؟

❖ در دومین بخش از حقوق مراجع، حق رضایت آگاهانه ذکر شده که: بعضی از جنبه های فرایند رضایت آگاهانه عبارتند از: اهداف کلی مشاوره، مسئولیت های مشاور در قبال درمانجو، محدودیت ها و موارد استثنای محرمانه بودن، متغیرهای قانونی

و اخلاقی که می‌تونن رابطه رو تعریف کنن. صلاحیت‌ها و پیشینه درمانگر، ویزیت، خدماتی که درمانجو می‌تونه انتظار داشته باشه، مدت زمان تقریبی فرایند درمان، منافع مشاوره، مخاطرات احتمالی و احتمال اینکه مورد درمانجو با همکاران یا سرپرستان درمانگر، در میون گذاشته شه. این فرایند آگاه ساختن درمانجو در جلسه اول مشاوره شروع میشه و در طول مشاوره ادامه داره.

161. نرم کردن و هنجاریابی تست‌های روان‌شناسی وظیفه‌اش به عهده چه کسی است و چه ارگانی است و چگونه می‌توان از این تست‌ها استفاده نمود؟

❖ هنجاریابی، تایین روایی و پویایی بر عهده ی روان‌شناسان و متخصصین آشنا با دانش روز و علم روانسنجی که توانایی‌های لازم رو داشته باشن. و تنها در صورتی که صلاحیت لازم برای استفاده از آن‌ها را دارند، می‌تواند به کار بگیرند.

162. اگر در زوج درمانی یکی از زوجین شکاکیت نسبت به مشاور و همسر خود داشته باشد روش ادامه درمان به چه صورت باید باشد؟

❖ (ص 43 اخلاق عاطف و دادور)، طبق قوانین انجمن خانواده درمانی آمریکا: خانواده درمانگر، باید از قضاوت عالی خود استفاده کنه. و اگر احساس کنه درمان جواب نمی‌ده به متخصص واجد شرایط ارجاع بده.

163. در درمان کارمندان بستگان و کارآموزان خود یک مشاور حرفه‌ای چگونه بایستی عمل کند؟

❖ نباید مداخله کند و در صورت لزوم به متخصص واجد شرایط ارجاع دهد.

164. منظور از حفظ حرمت دانشجویان و کارآموزان با توجه به اصول اخلاق حرفه‌ای چیست؟

❖ یعنی از ورود به حیطه‌های زندگی شخصی شون خودداری کنن. و از هر گونه رابطه‌ای که منجر به سوء استفاده می‌شه، اجتناب کنن.

165. اگر داده پژوهشی دچار دستکاری شود یا این داده‌ها فیک باشد؛ جرائم آن از دیدگاه سازمان روان‌شناسی به چه صورت می‌باشد؟
❖ در سازمان جریمه دکر نشده.

✚ دستورالعمل وزارت علوم از تاریخ 23/12/93 از این قرار است که:

جریمه در گزارش، متناسب با تخلف از طرف گروه تخصصی "بررسی تخلفات پژوهشی به هیأت تصمیم‌گیری و صدور حکم" (هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و کمیته انضباطی دانشجویان)

هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت علمی و کمیته انضباطی دانشجویان بر اساس آیین نامه‌های انضباطی مربوطه نسبت به صدور حکم اقدام می‌نماید. نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده معاونت پژوهش و فناوری "وزارت" و در گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی مؤسسات به عهده معاونت پژوهش و فناوری "مؤسسه" می‌باشد.

✚ طبق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی وزارت بهداشت جریمه‌ها به شرح زیر است:

ماده 1: هیأت رسیدگی به تخلفات پژوهشی می تواند پس از نتیجه گیری جریمه مناسب را در انتهای گزارش ارسالی به هیأت های انتظامی پیشنهاد نماید و هیأت های مذکور جریمه های ذکر شده در قوانین و مقررات تصریح شده در مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی، کارمندان و دانشجویان که از توییح شفاهی تا اخراج از دانشگاه و یا مؤسسه و انفصال دائم از خدمات دولتی برای متخلف در نظر خواهند گرفت.

تبصره 1: در موارد تخلفات پژوهشی فصل اول دستورالعمل که بسیار شدید ارزیابی می شوند، باید جریمه مناسب و بیش از توییح کتبی با درج در پرونده برای متخلف در نظر گرفته شود.

ماده 2: علاوه بر اقداماتی که توسط هیأت های انتظامی اعضای هیأت علمی و کارکنان، و کمیته انضباطی دانشجویی صورت خواهد گرفت، هیأت رسیدگی می تواند جریمه های زیر به تناسب موضوع از مراجع ذیربط در دانشگاه/مؤسسه تقاضا نماید: الف) خارج کردن مقاله و مقالاتی که از پژوهشی که بر اساس تخلف صورت گرفته است توسط مجله و اعلام آن در مجله. ب) توقیف فرد متخلف از ادامه همکاری در پروژه های پژوهشی با مدت معلوم توسط شورا یا شوراهای پژوهشی مرتبط. ج) در نظر گرفتن ناظر مستقیم بر فعالیت های پژوهشی بعدی متخلف به مدت یک الی سه سال توسط شورا یا شوراهای پژوهشی مرتبط.

د) جبران خسارت وارد شده به بیماران، حمایت کننده مالی و امکانات دولتی مطابق قوانین موجود. و) کم کردن نمره پایان نامه و یا تکرار پایان نامه با موضوع جدید در صورتی که تخلف در پایان نامه دانشجوی رخ داده باشد توسط معاونت آموزشی دانشگاه یا مؤسسه مرتبط.

ه) اعلام عمومی تخلف صورت گرفته توسط فرد در دانشگاه، مؤسسه و یا مرکز پژوهشی.

166. قوانین سخنرانی در رادیو و تلویزیون از دیدگاه سازمان روان شناسی به چه صورت است؟

❖ *باید سخنرانی ایشون، بر پایه دانش به روز روان شناختی و تجربه های حرفه ای استوار باشد. *باید صحبتها منطبق با اصول اخلاق حرفه ای در روان شناسی باشد. *نباید دلالت بر اون داشته باشد که رابطه حرفه ای با مخاطب برقرار شده.

167. آیا یک مشاور می تواند در رویدادها و ایونت های عام المنفعه شرکت کند ضوابط این شرکت از دیدگاه سازمان روان شناسی چیست؟

❖ می تونه.

*باید از هرگونه اظهارات غیر واقعی و نابجا، در زمینه ی آموزش های تخصصی، تجارب حرفه ای، شایستگی ها، درجات تحصیلی، مدارک، وابستگی های سازمانی یا انجمنی، خدمات، علمی و بالینی تألیفات و تحقیقات خود اجتناب کند. *باید هم از صحت مطالب ارائه شده توسط آنان اطمینان حاصل کنند، بر فرایند تبلیغات نظارت نمایند و مسئولیت آن را بر عهده گیرند.

168. اگر یکی از زوجین اطلاعات همسر خود را در رابطه با زوج درمانی از مشاور خواست مشاور به چه صورتی بایستی عمل کند

که دچار جرایم سازمان نظام نشود؟

❖ بدون آگاهی و رضایت از آن فرد یا زوج نباید در اختیار بگذارد. و اینکه نباید به گونه ای عمل کند که زوجین در مقابل یکدیگر قرار بگیرند. مصایق افشاء در نظام نامه را نیز در نظر بگیرد.

169. آیا بعد از فوت یک مراجع می توانیم اطلاعات آن را به خانواده ارائه دهیم یا به دادگاه؟

❖ در صورت وجود دستور قضایی می شود.

170. اگر مطلع شدید که فردی قصد آسیب زدن به همسر خودشو داره؛ چه می کنید؟

❖ مراجع انتظامی ذی ربط باید در جریان گذاشته شوند.

171. از رفتارهای بی احترامانه درمانگران؟

❖ عدم حضور در جلسه مشاوره/ روان درمانی و یا فراموش کردن وقت آن - لغو وقت جلسه مشاوره/ روان درمانی بدون ارایه برنامه جایگزین - تغییر خودسرانه در سیاست های خود با مراجع (به عنوان مثال تغییر سیاست تلفن، هزینه، زمان ملاقات - عدم پاسخ یا تاخیر در پاسخ به پیام ها و تماس های تلفنی - گم کردن کاغذها، فایلها و یادداشتها - نخواندن یادداشتها و نوشته هایی که مراجع داده است - دیر رسیدن به جلسه مشاوره/ روان درمانی - داشتن ظاهر یا پوشش غیر حرفه ای - داشتن بهداشت فیزیکی ضعیف - کثیف بودن فضای دفتر مشاوره/ روان درمانی - کشیدن سیگار در جلسه مشاوره/ روان درمانی - خوردن/ جویدن آدامس در جلسه مشاوره/ روان درمانی - بسته نبودن در اتاق به هنگام جلسه مشاوره/ روان درمانی - اجازه دادن روان شناس به وجود موارد مزاحمی نظیر تماس تلفنی یا پیام - بی توجهی یا درگیر فعالیتهای دیگر شدن به هنگام جلسه و یا تماسهای تلفنی با مراجع - فراموش کردن اطلاعات مهم مراجع (نام، اطلاعات و تاریخچه مرتبط) - تکرار حرف های خود و اغلب فراموش کردن آنچه مراجع گفته است - به طور بارز خسته به نظر رسیدن - چرت زدن در حضور مراجع - اجتناب از تماس چشمی - صحبت کردن در مورد سایر مراجعان - نگاه کردن به ساعت در جلسه مشاوره/ روان درمانی - اتمام زودهنگام جلسه - مخاطب قرار دادن مراجع با لحنی پدرسالارانه یا مادرسالارانه و غیر متناسب با اصول روان درمانی - رفتار با مراجع به گونه ای که پایین تر از درمانگر است (میلر، ۱۹۹۰ به نقل از لینهان، ۱۹۹۳)

172. چه سؤالاتی حق مراجع است؟

❖ در مورد هزینه؛ مراجع حق دارد که قبل از وقت گرفتن و شروع جلسه درمان از هزینه ها مطلع شود. طبیعی است که هزینه های درمان برای برخی از مراجعان نگران کننده است و این موضوع ممکن است باعث شود مراجع نتواند به خوبی از جلسه درمان استفاده کند. حق این را دارد که این موضوع را با درمانگر خود مطرح کند.

در مورد رویکرد درمانی؛ حق دارد راجع به رویکرد درمانی مشاور خود مطلع شود و به طور خاص سؤال کند که برای درمان از چه رویکردی استفاده می کند.

در مورد روند درمان؛ می تواند راجع به روند درمان خود از مشاور سؤال کند. این که آیا درمان خوب پیش می رود یا نه؟ سرعت درمان افزایش پیدا کرده یا کاهش؟ و این که چه موانعی سر راه روند درمان وجود دارد.

در مورد تخصص مشاور؛ اجازه دارد راجع به رزومه و تخصص مشاور سؤال کند. این که چند سال سابقه درمانگری دارد یا مدارک خود را از چه دانشگاه هایی کسب کرده؟ پروانه کار دارد یا خیر؟ در چه زمینه ای به طور تخصصی مشاوره می دهد و مهارت دارد؟

در مورد سؤالات شخصی چه؟ بعضی مراجعان از سرکنج کاوی به دنبال دریافت اطلاعات شخصی از درمانگر خود هستند. توجه کنید که درمانگر اجازه دارد به این گونه از سؤال ها جواب ندهد یا حتی برایش سؤال شود که با چه انگیزه ای این سؤال ها را مطرح می شود. از طرفی هم می تواند انتخاب کند که به سؤالات مراجع جواب دهد یا خیر. اما توجه داشته باشید که جلسه درمان با هدف رفع نیاز های مراجع صورت می گیرد و نباید زمان صرف مسایل شخصی زندگی مشاور شود. در کل بهتر است اطلاعات اضافی که در روند درمان تاثیری ندارد مطرح نشود چرا که ممکن است باعث سوگیری مراجع شود و می تواند روند درمان را مختل کند. اگر مراجعی هم احساس کند که سؤال مشاور بی ربط بوده و در چهارچوب کار درمانی نمی گنجد و یا فعلاً آمادگی لازم برای پاسخگویی به سؤال خاصی را ندارد و باید اعتماد بیشتری ایجاد شود که به سؤال مشاور پاسخ دهد می تواند از پاسخ دادن امتناع کند و دلیل و احساس خود را نسبت به سؤال مطرح شده ابراز نماید.

173. خود مختاری مراجع در مورد زمان مشاوره؟

❖ حق دارد در تعیین زمان مشاوره تا حد زیادی دخیل باشد و با توجه به زمان های خالی خودش و زمان هایی که مشاور در مرکز فعالیت می کند یک ساعت مشخص را با منشی هماهنگ کند که برایش مفیدتر باشد. ممکن است بر اثر یک مشکل فوری یا دلیل خاصی بخواهد جلسه را کنسل کند و اگر 24 ساعت قبل از زمان مشخص شده برای مشاوره، تصمیم به لغو جلسه بگیرد نیازی نیست هزینه ای برای مشاوره پرداخت کند اما توجه داشته باشید اگر کمتر از 24 ساعت به جلسه درمان مانده باشد و بخواهد جلسه را لغو کند، باید تمام هزینه مشاوره را پرداخت کند. در مورد اتمام درمان؛ معمولاً با تشخیص مشاور تعیین می شود که درمان باید ادامه پیدا کند یا تمام شود اما ممکن است به هر دلیلی، مراجع تمایل به ادامه درمان نداشته باشد و تصمیم بگیرد دیگر به مشاوره ادامه ندهد. این حق را دارد هر زمان که خواست به هر دلیلی به جلسات مشاوره خود پایان دهد و از منشی بخواهد برای هفته های آینده دیگر وقت مشاوره تعیین نکند.

174. درخواست ارجاع از سمت مراجع مقدور است؟

❖ می تواند از مشاور خود درخواست کند که او را به یک مشاور دیگر ارجاع دهد. این ممکن است برای یک موضوع خاص باشد یا درخواست ارجاع کامل داشته باشد. گرچه لازم نیست دلیل درخواست ارجاع را به طور کامل و با جزئیات توضیح

دهد اما بهتر است مشاور کمی راجع به این موضوع اطلاعات پیدا کند تا بتواند به بهترین نحو او را به شخص مفیدتر ارجاع دهد. درمانگر حرفه‌ای برای مراجع تصمیم نمی‌گیرد. اگر درمانگر درباره ازدواج، بچه دار شدن، مهاجرت یا هر تصمیم بزرگ یا کوچک دیگر، به صورت مستقیم نظر یا دستوری ابراز کرد، احتمالاً در مسیر مخالف درمان و استقلال در حرکت هستند.

175. ضبط الکترونیکی جلسات قانونی و اخلاقیست؟

❖ بعضی از مشاوران جلسات درمان را ضبط می‌کنند تا بعداً برای درمان بهتر، تجربه‌های شخصی، یا دلایل حقوقی از آن‌ها استفاده کنند. توجّه داشته باشید که این فقط با رضایت شخص مراجع ممکن است در غیر این صورت مشاور حق ندارد جلسه را ضبط کند. توجّه داشته باشید اگر مراجع هم خواست، می‌تواند جلسه را ضبط کند تا بعداً برای بهبود روند درمان به آن مراجعه کند.

پ.ن 1: اگر در رابطه با پرسش و پاسخ‌ها مسئله‌ای بود، به آیدی @Skyfalling007 مراجعه فرمایید.

پ.ن 2: با تقویت اعمال فرهنگ کپی رایت و رعایت استنادی علمی، در کانال‌های تلگرامی، به ایجاد فضای مشارکتی صمیمی و پیشرفت حرفه‌ای کمک کنید.